يونيسف
لكل طفل

وزارة الصحة العراقية
IRAQI MINISTRY OF HEALTH
FOUNDED 1920 تأسست

جمهورية العراق
وزارة الصحة



المدرسة والصحة النفسية

كراس مخصص للتربويين

2022

اعداد
شعبة الصحة النفسية
دائرة الصحة العامة

المدرسة و الصحة النفسيه

كراس مخصص للتربويين

الاشراف العام

مدير عام دائرة الصحة العامة

وزارة الصحة

اعداد

د.سارة احمد خليل

طبيبة اختصاص

شعبة الصحة النفسية

اللجنة الفنية المشرفة على مراجعة الدليل

د.اروى عبد الخالق علي

مديرة شعبة الصحة المدرسية

ر. اطباء اسنان اقدم

د.ثناء حسين محمد صالح

شعبة الصحة المدرسية

ر.اطباء اختصاص اقدم

د.شيماء محمد جواد ابراهيم

منظمة الامم المتحدة للطفولة

طبيبة اختصاص

د. نغم جلوب العنزي

الكلية التربوية المفتوحة

ر. ابحاث اقدم

سامر لطيف حمد

المديرية العامة للتربية

الرياضية

ر.ملاحظين

د.مهدي صالح بلاسم

مستشفى الرشاد التدريبي للامراض

النفسية و العقلية

طبيب اختصاص

المحتويات :

الموضوع	الصفحة
المقدمة	1
اهداف الدليل	2
الفصل الاول:الصحة و الصحة النفسية و الصحة النفسية المدرسية	7-3
الابعاد و العوامل المؤثرة على الصحة النفسية	3
الصحة النفسية والمجتمع المدرسي	4
خصائص البيئة المدرسية المعززة للصحة النفسية	6-4
دور المدرسة في تعزيز الصحة النفسية للطالب	6
الفصل الثاني:خصائص ومعايير النمو والقياس	12-7
عوامل الخطورة على نمو الطفل نفسيا	11
الفصل الثالث: عوامل الاختطار والوقاية على مستوى الفرد والاسرة والمجتمع	15-12
الفصل الرابع:مهارات التواصل للكوادر التدريسية	17-15
الفصل الخامس:مستويات التداخل والرعاية النفسية	23-17
الفصل السادس:المشكلات النفسية الاكثر شيوعاً الاطفال واليافعين وعوامل الخطورة لها والوقاية منها	34-23
الاضطرابات العاطفية (القلق العام، الاكتئاب، الخوف من المدرسة،الكرب ما بعد الصدمة، الفصام التبول اللاارادي الليلي)	26-23
الاضطرابات السلوكية (فرط الحركة، السلوك العدواني)	28-26
الاضطرابات النمائية الشاملة (طيف التوحد)	28
مشاكل معرفية (بطء التعلم، التأخر الدراسي)	29
اضطراب الكلام(التأتأة)	30
التنمرالمدرسي	32-30
نظام الاحالة بالنسبة للطلبة المشاكسين	32
دور الاسرة في الرعاية الصحية النفسية	32
الوصايا الاساسية للتربية النفسية السليمة	33

الفصل السابع: الحالات الخاصة (الاعاقة البدنية، الاعتداء الجنسي على الاطفال واليافعين)	37-34
الملاحق : ـ الانشطة الترفيهية لتلبية احتياجات /اهتمامات الطلاب ـاهمية الصحة النفسية للمعلم / المدرس ـاسماء المشاركون في مراجعة الدليل	44-37
المصادر	44

المقدمة

الصحة من الامور التي انعم الله بها على عباده وامرهم بالحفاظ عليها , حتى ان الحكماء قديما قالوا الصحة تاج على رؤوس الاصحاء هذا يعني القيمة الكبيرة للصحة لكي يصفها الحكماء بهذا الوصف الدقيق فيجعلوها تاجا على الرؤوس . الصحة النفسية التي نحظى بها تجعلنا اكثر طمأنينة و سكينة مع انفسنا و تجعل حياتنا اكثر توازنا لكي نقوم بجميع المهام والواجبات المطلوبة منا ، و بالتالي وجود مجتمع مدرسي يحقق للطالب الصحة النفسية والراحة النفسية التي تساعده على استيعاب المناهج بسهولة وبدون أي ضغط من الأهل أو المدرسة، يساعد على نشوء طالب سوي نفسيًا يستطيع أن يكون سببًا في تطور وازدهار المجتمع .

تماشيا مع خطة الصحة النفسية والتحديثات الاخيرة في دليل تداخلات برنامج رأب الفجوة في الصحة النفسية (MhGAP) لمنظمة الصحة العالمية العالمية/الاصدار الثاني و مبادرات منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الخاصة بدعم الصحة النفسية للاطفال و اليافعين وبالنظر الى تزايد الاضطرابات النفسية وفقا لاحصائيات وحدات الصحة النفس – اجتماعية في محافظات العراق كافة اصبح من الضروري الحاجة الى تدريب الكوادرالتربوية في المدارس والكوادر الصحية في مراكز الرعاية الصحية الاوليه للتعامل مع شتى الضغوط النفسية للطلاب ووضع خطة عمل تمكنهم بعد تدريبهم بالشكل المناسب من ان يقدموا خدمات صحية مدرسية تتعلق بالصحة النفسية ويطوروها لاحسن صورة ممكنة .

نأمل أن يلبي هذا الكراس بعضا من حاجة التربويين في مجال الصحية النفسية المدرسية

والله ولي التوفيق

د. رياض عبد الامير الحلفي
مدير عام دائرة الصحة العامة
وزارة الصحة

اهداف الدليل :

- التعرف على عوامل الخطورة والوقاية والتدخلات المناسبة في مجال الصحة النفسية للطلاب. وذلك لتحقيق :
  - تعزيز الصحة النفسية المدرسية والوقاية من الاضطرابات النفسية.
  - الرعاية والمتابعة .
- زيادة الوعي بحجم المشاكل النفسية والآليات المقترحة للتصدي لها.
- تطوير مهارة المعلمين و المدرسين في مجال الاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية وكيفية التعامل معها.
- تطوير الأساليب الناجحة في التعامل مع الطلاب داخل المدرسة، وطلب الاستشارة المتخصصة عند الحاجة.
- تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات لخدمة فئة الطلاب ، وضمان تواصل الخدمة المقدمة لهم.



الفصل الاول: الصحة ، الصحة النفسية ، والصحة النفسية المدرسية: المفاهيم والمصطلحات والادوار

الصحة: حسب تعريف منظمة الصحة العالمية (هي حالة المعافاة التامة جسديا ونفسيا واجتماعيا وليست الخلو من المرض أو العوق فقط) و اضيفت اليها مؤخرا العافية الروحية و هي القيم و المعتقدات التي تدير سلوك الفرد و تصرفاته وهذا التعريف يبين بوضوح أن المعافاة النفسية هي مكون أساسي في الصحة؛ حيث لا تتحقق حالة الصحة التامة إلا بتحقق الصحة النفسية للفرد أو المجتمع.

الصحة النفسية: حسب تعريف منظمة الصحة العالمية (هي حالة من العافية التي يستطيع فيها الفرد إدراك إمكاناته الخاصة والتكيف مع حالات التوتر العادية والعمل بشكل منتج ومفيد والإسهام ايجابيا في مجتمعه المحلي).

ان اهم علامات تمتع الفرد بالصحة النفسية هي:

١. معرفة القدرات والإمكانات الحقيقية للذات والسعي للأستفادة منها وتطويرها، ومعرفة السلبيات والاعتراف بها والعمل على تجاوزها.

٢. القدرة على التعامل السليم مع ضغوط الحياة اليومية المعتادة ومواجهتها بشكل إيجابي وباعتدال بعيدا عن السلبية والانفعالات المبالغ فيها.

3. القدرة على إقامة علاقات اجتماعية سليمة مع الآخرين وإدامة تلك العلاقات.

4. القدرة على العمل والإنتاج المثمر وعلى العطاء لتطوير نفسه وعائلته ومجتمعه.

ه. (السلوان) هى المرونة والثبات أمام الأزمات والقدرة على مداواة الذات وتجاوز الأزمات النفسية.

و بصيغة اخرى يمكن تعريف الصحة النفسية على انها : حالة من الاحساس الايجابي بالرضا عن الذات المتصفة بالتوازن (حالة التوافق بين افكار و مشاعر و سلوك الفرد و انسجامها مع القيم و الاعراف و التقاليد و العادات السائدة في المجتمع.

أبعاد الصحة النفسية ثلاثة هي : الأفكار و المشاعر و التصرفات (السلوك)

و لتقييم الحالة الصحية النفسية للفرد لابد من تقييم تلك الابعاد (افكاره، مشاعره، سلوكه) وادائه الوظيفي والمجتمعي.

المرض النفسي: هو حالة وجود خلل في أفكار الفرد أو مشاعره أو تصرفاته وتكون مزعجة له أو للآخرين مع تردي في الأداء الوظيفي والمجتمعي وحسب شدة المرض.

العوامل المؤثرة على الصحة النفسية:

- عوامل بايلوجية: وجود عامل وراثي لدى العائلة , المرحلة الجنينية من حياة الطفل وما تعرضت له الأم من امراض او شدة او اشعاع او عقاقير اثناء الحمل أو التعرض للشدة اثناء الولادة , سمات شخصية الفرد , اعتلال الصحة الجسدية, وتعاطي المواد المخدرة.
- عوامل نفسية واجتماعية: مثل تعرض الفرد في بداية حياته الى اليتم، التشرد، الأعتداء الجنسي وغيرها , تعرضه الى الشدة النفسية (الكروب), الفقر, تدني مستوى التعليم, انتهاك لحقوق الانسان والتمييز.

- الصحة النفسية والمجتمع المدرسي:

إن الحفاظ على سلامة الصحة النفسية وتعزيزها بالنسبة للطلاب والكادر التربوي يمثل امرا مهما ، وذلك من خلال مواجهة ما يمر به بعض الطلاب من مشكلات قد تعوق النمو النفسي السليم لديهم، والتي تؤثر تأثيرا كبيرا على قدرتهم على الاستيعاب والفهم، ومن ثم على تحصيلهم الدراسي وصحتهم النفسية كما إن سلامة الحالة النفسية للطالب تزيد من ثقته بنفسه واحترامه لذاته، وتدعم قدرته على اتخاذ القرارات السليمة، وتجنبه السلوكيات الخاطئة .

ان أهداف التربية تلتقي مع أهداف الصحة النفسية حيث أن المدرسة تعمل على تكوين شخصية التلميذ تكوينا شاملا من النواحي الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية ومن هنا ندرك أن العلاقة بين أهداف المدرسة وأهداف الصحة النفسية هي علاقة وطيدة لذا لا بد للمدرسة والتربية بوجه عام أن تحدث التأثير الإيجابي المرغوب عند الطلبة .

وان تقديم خدمات الصحة النفسية المدرسية تتم بالتعاون والتكامل ما بين المؤسسات الصحية (وحدة الصحة النفس - اجتماعية ومسؤول وحدة الصحة المدرسية في المركز الصحي, مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية ,اللجان الطبية) وبين المدراء , الملاكات التربوية المرشدين التربويين أو المنسق الصحي او من يقوم مقامهم في المدارس وبمشاركة اسرة الطالب أو القائمين على رعايته .

اثر الصحة النفسية السليمة على المجتمع المدرسي:

الاثر على التعليم:

. يقلل من التسرب الدراسي.

. يقلل من الغياب عن المدرسة.

. انخفاض السلوكيات غير المرغوبة في المجتمع المدرسي.

. زيادة نسب النجاح والتفوق.

الاثر على الطلاب:

. يساعدهم في بناء علاقات متينة مع أقرانهم ومع المجتمع.

. يزيد من قدرتهم على الثبات في الأزمات والشدائد.

. المحافظة على الشخصية المتكاملة .

. التوافق والتكيف مع الواقع والمعايير الاجتماعية.

. تحقيق النجاح في الحياة

خصائص البيئة المدرسية المعززة للصحة النفسية :

ما هو تعزيز الصحة في المدارس؟

هو اي نشاط يتم القيام به لتحسين و /او حفظ صحة جميع افراد المجتمع المدرسي .و لهذا فهو مفهوم اوسع من التثقيف الصحي .

برزت مجموعة من المعايير التي تعزز الصحة النفسية داخل المدارس،هذه المعايير هي معايير عالمية تمت موائمتها لتعتمد في العراق كمعايير للصحة النفسية و تكون متوافقة مع واقع مدارسنا حيث تم اختيار 25 مدرسة من كل محافظة لتكون مدرسة معززة للصحة النفسية وهناك خطة لتوسعة هذا العدد حتى تشمل اغلب مدارس العراق وهذه المعايير هي :

معايير تتعلق ببيئة صحية مدرسية متكاملة (حسيا ونفسيا واجتماعيا) :

- توفر بيئة حسية آمنة ونظيفة ومطابقة للمواصفات والشروط الصحية المعتمدة في مختلف النواحي البيئية .
- وجود مرشد تربوي او منسق صحي في المدرسة يتابع مشاكل وقضايا الطلاب النفسية، ويقدم الخدمات الارشادية المناسبة وذلك حسب ما اقره قانون مكتب الخدمات النفسية والخدمية والاجتماعية وفق المادة (21) لسنة 1983.
- تطبيق البرامج التوعوية والارشادية للوقاية من الاضطرابات النفسية والسلوكية .
- تطبيق برامج لاكتشاف الحالات النفسية، والاجراءات المتخذة حيالها، والحالات المحالة للجهات الصحية، وتوفير سجلات توثق فيها الحالات وحسب ما اقره قانون مكتب الخدمات النفسية والخدمية والاجتماعية وفق المادة (18) لسنة 1983 .
- توفر الرعاية النفسية الخاصة للطلاب المضطربين نفسيا وسلوكيا وذوي الاحتياجات الخاصة، والتنسيق مع الجهات الصحية للمتابعة والتقييم .
- تضمين مشاركات الاهل والمؤسسات الاجتماعية الاخرى في البرامج والانشطة النفسية المدرسية المختلفة .
- مشاركة الطلاب في مختلف النشاطات التي تتعلق بالصحة النفسية وإتاحة الفرصة للتعبير عن آرائهم حول القضايا والمشاكل التي تهمهم .

معايير تتعلق بالكادر التربوي

- توفر كادر ملم ومتدرب على مفاهيم الصحة النفسية لتعليم السلوك والشخصية السوية والتوافق النفسي للطلاب ويتم ذلك من خلال التنسيق مع وزارة التربية .
- التعرف والاطلاع على أهمية الصحة النفسية للطالب، وأسس تعزيزها داخل المدرسة.
- الالمام بمراحل النمو ومتطلباتها، وأسس التعامل مع كل مرحلة عمرية مختلفة .
- الالمام بمهارات التواصل، وأساليب تعليم مهارات الحياة .
- معرفة طرق وأساليب الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية وأساليب التعامل معها .
- وجود علاقات اجتماعية طيبة بين المعلمين داخل البيئة المدرسية، تقوم على أساس المحبة والاحترام والتعاون المتبادل ويتم ذلك من خلال التنسيق مع وزارة التربية .

معايير تتعلق باكتساب المهارات

- التركيز على مهارات الحياة وتعلمها.
- التناسب مع البيئة والقيم الاجتماعية المختلفة والسلوكيات المحيطة بها.
- تخصيص جزء من أنشطة وفعاليات التوعية الصحية للصحة النفسية مثل محاضرات ندوات، معارض، ورش عمل(وتوجيهها لتعديل السلوك وتقويمه).
- ضرورة اضافة النشرات والملصقات المعززة للصحة النفسية في المدارس مع توفير كراس المدرسة والصحة النفسية المخصص للتربويين.
- تحفيز الطالب لزيادة مهاراته وقابلياته وتقليل الاضطرابات والضغوطات النفسية عليه.
- تضمين مواضيع صحة النفس الاجتماعية ضمن المفردات الدراسية والنشاطات الفنية (النشاطات المدرسية ، مادة الانشاء ، درس الفنية).

توفير تقارير وسجلات واحصائيات منظمة للامراض والاضطرابات النفسية والخدمات المقدمة لهم وحالات الاحالة للجهات الصحية عند الحاجة و تشمل ما يلي :

- الذين يعانون من تكرار حالات تدني مستوى التحصيل الدراسي الذين يعانون من تكرار حالات الرسوب .
- الذين يعانون من تكرار حالات التغيب في المدرسة و الذين يتسببون في تكرار حالات العنف المدرسي .
- الذين يعانون من مشاكل اجتماعية داخل اسرهم والذين يعانون من حالات مرضية مزمنة.
- الذين يعانون من إعاقات وتشوهات جسمية بمختلف أنواعها، والذين يعانون من مشاكل عاطفية وسلوكية او نمائية.
-عدد حالات الادمان ، عدد حالات العنف والاعتداء وخرق القوانين، عدد حالات الاعتداء والتحرش الجنسي.

افكار لامثلة تطبيقية حول ادخال مواضيع و مفاهيم الصحة النفسية ضمن المناهج الدراسية و حسب مدى استيعاب كل فئة عمرية للدرس:

درس الانشاء - اكتب ما تعرفه عن اضرار المخدرات على صحة الانسان .
- اكتب ما تعرفه عن ظاهرة التنمر و تأثيراتها على الصحة النفسية .

درس الفنية - عبر عن شعورك الان برسمة من مخيلتك .
- مثل بالرسم العلاقة بين ادمان المخدرات و صحة الانسان.

درس الرياضيات - اذا كان 4 من بين 10 اشخاص مصابين بالاكتئاب يقدمون على الانتحار فكم عدد المقدمين على الانتحار من بين 20 شخص مكتئب؟
- اذا كان ادمان المخدرات يقتل 10 شباب باليوم الواحد فكم يكون عدد ضحايا ادمان المخدرات خلال اسبوع؟

درس الرياضة – يقوم معلم او مدرس الرياضة بكتابة اسماء المخدرات الشائعة على الارض و ثم يقسم الطلاب الى فريقين ويقوم التلاميذ في كل فريق بمحاولة القفزبقدم واحدة (القدم الثانية مرفوعة) على كل اسم مكتوب من انواع المخدرات و الفريق الفائز هو الفريق الذي ينجح بتحقيق اكبر عدد من القفزات على المخدرات .

- **دور المدرسة في تعزيز الصحة النفسية للطالب :**
- المساعدة في اكتمال نمو الشخصية السليم. (التنشئة السليمة)
- التاكد من توفر البيئة المناسبة للتربية والنمو النفسي السليم.
- زيادة المعارف وتطوير المهارات النفسية والاجتماعية وتشجيع السلوك الإيجابي للطالب.
- مساعدة الطالب على التعرف على خصائص نفسه وفهم قدراته وميوله واختيار التخصص المناسب له.
- مساعدة الطلبة الذين يعانون من مشكلات نفسية واجتماعية حتى يتحقق لهم التوافق مع أنفسهم ومع الاخرين.
- العمل على اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتوفير الامكانات والفرص المتاحة لتنمية مواهبهم.
- الاهتمام بحالات التأخر المدرسي والعمل على دراسة الأسباب ومعالجتها.
- الاهتمام ورعاية الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

تؤثر العلاقات الإجتماعية في المدرسة على الصحة النفسية للطالب على النحو التالي:

- العلاقات بين المدرس/ المعلم والتلميذ التي تقوم على أساس من الديمقراطية والتوجيه والإرشاد السليم تؤدي إلى حسن العلاقة بين المدرس/ المعلم والتلميذ وإلى النمو التربوي والنفسي السليم.
- العلاقات بين التلاميذ بعضهم البعض التي تقوم على أساس من التعاون والفهم المتبادل تؤدي إلى الصحة النفسية السليمة.
- العلاقات بين المدرسة والأسرة والتي تكون دائمة الإتصال (وخاصة عن طريق مجالس والآباء والمعلمين) تلعب دورا هاما في إحداث عملية التكامل بين الأسرة والمدرسة في عملية رعاية النمو النفسي للتلاميذ.

الفصل الثاني: خصائص ومعايير النمو والقياس:

لماذا الاهتمام بالنمو النفسي للطفل؟

وذلك لمعرفة أحسن الوسائل الممكنة للحفاظ على الصحة النفسية للطفل، الوقاية من الانحرافات والاضطرابات النفسية، الاكتشاف المبكر لأي منها بهدف التعامل الصحيح معها، الوصول إلى أفضل المستويات الممكنة من الحياة السوية الصحية

اهم جوانب نمو الطفل:

آن جوانب النمو للطفل متعددة وتتفاعل مع بعضها لتؤثر في الشكل الكامل والنهائي للبناء النفسي للفرد الذي يعتمد على الصفات الخلقية للطفل (البنية) وظروف تنشئته (المحيط) والتفاعل بين هذين المحددين، واهمها :

النمو الجسمي: (نمو الطول، نمو الوزن، الاسنان اللبنية والدائمة، النمو الفسيولوجي والتي تشمل معدل التنفس، دقات القلب، ضغط الدم، عدد الوجبات الغذائية وساعات النوم التي يحتاجها)

النمو الحركي: (الحاسة العضلية، حاسة اللمس، حاسة السمع، حاسة البصر، الفروق الفردية بين الجنسين في الناحية الحركية) .

النمو العقلي: (اكتساب المعرفة، التفكير المجرد، حب الاستطلاع، تمايز القدرات)

النمو اللغوي: (تعلم القراءة، تكوين الجمل، القراءة الجهرية والصامتة، التعبير الشفوي والتحريري) .

النمو الانفعالي: (تكوين العواطف ويتضمن البكاء والغضب والحب والكره والخوف والبهجة)

النمو الاجتماعي: (السمات الذاتية، التعاون، العادات، الولاء للأصدقاء، الفروق بين الجنسين، المكانة الاجتماعية)

مراحل النمو و تأثيرها على الصحة النفسية للفرد :

ان شخصية الفرد تتكون وتتشكل في السنوات الأولى فقط من حياته أما ما يتعرض له الفرد فيما بعد من تأثيرات فإنها تبقى ثانوية بالنسبة لما يكون قد تعرض له في مرحلة الطفولة ، فعناصر شخصية الفرد تعود إلى مرحلة الطفولة وما يتعرض له الفرد من خبرات إيجابية أو سلبية.

1) الاخصاب
2) الجنين
٣) الولادة
4) مرحلة مابعد الولادة والطفولة
   السنة الاولى السنة الثانية
   السنة الثالثة - السنة الخامسة
   السنة السادسة - السنة العاشرة
5) مرحلة المراهقة (10 – 19 سنة)

مرحلة الإخصاب

- وجود أي خلل في حيمن الرجل أو بويضة المرأة قد يسبب اضطرابات نفسية أو جسدية لدى الطفل.
- تبرز هنا أهمية اجراء الفحص والمشورة الطبية قبل الزواج والحمل.
- ينصح بتجنب زواج الأقارب عند وجود مرض وراثي .
- ينصح بالإجراءات اللازمة عند عدم تطابق دم الزوجين (عامل Rh) وبأنه ليس مانعا للزواج .
- زيادة عمر الأبوين ترافقها زيادة ملحوظة في احتمال ولادة طفل منغولي.
- اكتشاف بعض الأمور قبل الزواج والحمل، مثل الاصابة بفيروس التهاب الكبد الفيروسي أو فيروس نقص المناعة المكتسب أو الأخماج (الالتهابات) المنقولة جنسية لغرض اتخاذ اللازم بشأنها من أمور التوعية والوقاية والمعالجة .
- ان الحمل المرفوض (الطفل الغلطة) يؤثر سلبيا في حياة الطفل مستقبلا بشكل أو بآخر رغم حب الأم له بعد ولادته ورعايتها له فمن الضروري جدا أن يكون الأبوان راغبين فعلا بالحمل وبالطفل المنتظر.

مرحلة الحمل (المرحلة الجنينية)

في هذه المرحلة تتجلى أهمية الفحص الدوري للحامل لمتابعة الحالة الصحية والتغذوية لها وللجنين والإكتشاف المبكر لعوامل الخطورة والتصرف أزاءها. أضافة لتقديم النصح والإرشاد للحامل، فهناك عوامل عديدة قد تتعرض لها الحامل وتؤثر في مستقبل الطفل المنتظر ومنها مثلا :

/ تناول الأدوية / التعرض للإشعاعات الضارة / الإصابة بالأمراض المختلفة (كالحصبة الألمانية، السفلس، الأيدز .. الخ). / مشاكل عدم تطابق الدم بين الأم والجنين / مشاكل سوء التغذية وخاصة نقص اليود، الفولك أسيد ... الخ.

مرحلة الولادة

إن تعرض الطفل :

- لقلة الأوكسجين،
- تأخر الولادة وتعسرها،
- أية شدة على الرأس قد تسبب ضرر في الدماغ،

وكل هذه عوامل قد تسبب أضرارا نفسية وعصبية مستديمة ان لم تسبب الوفاة. لذا لابد أن تتم الولادة بمساعدة أيد أمينة ماهرة متدربة على التعامل مع كل الإحتمالات أثناء الولادة .

مرحلة مابعد الولادة والطفولة

بعد الولادة يأتي كائن جديد منفصل جسديا عن أمه. حين يولد الطفل يكون حجم دماغه حوالي ثلثي حجم الدماغ الناضج .

- إن توفر الغذاء المناسب ضروري جدا لهذا النمو مما يستوجب الإلتزام بالرضاعة الطبيعية التي توفر الغذاء الأنسب وتعطي الإحساس بالأمان والطمأنينة والثقة للطفل.
- كما يستوجب توعية الأمهات بأنواع الأغذية التكميلية التي يجب اعطاؤها للطفل والعمر الذي تعطى فيه .

ضمن عوامل النمو النفسي للطفل التي تؤثر على نشأته ما يلي :

1.العوامل الاجتماعية

وتلك التي تتشكل من العالم الخارجي مثل الأسرة ،الأصدقاء ، المجتمع وغيرهم وتؤثر بشكل كبير على التفاعل والمشاركة في البيئة المحيطة وتقبلها.

2.العوامل الطبقية

وتكون متمثلة في المستوى الطبقي الذي نمى فيه الطفل، مستوى التعليم والمستوى المادي والوظيفة التي يمتلكها الفرد والتي قد تجعله يعيش في مستوى مادي عالي أو منخفض أو متوسط.

3.العوامل الثقافية

و تأتي بما يتلقاه الطفل من تعليم جيد ، طريقة التربية السليمة و اسلوب تعامل الطفل مع الوالدين و التي تحدد لديه بعض المعتقدات و القيم و المبادئ التي يعتنقها في دورة حياته .

وندرج فيما يلي بإيجاز السمات العامة للمراحل العمرية:

السنة الاولى من العمر:

في نهاية السنة الاولى من العمر يكون الطفل علاقة وطيدة مع الأم والآخرين في الأسرة، يكون هناك انتظام أوقات النوم والأكل، يتعلم تمييز الأشياء في بيئته تدريجيا ويكون علاقات سببية بين الأشياء والظواهر حوله، ويتمكن من نطق بعض الكلمات مثل بابا، ماما، دادا ويستمتع بذلك

السنة الثانية من العمر:

- يبدو وكأنه يرغب بإرضاء والديه ويقلق إذا أحس بزعلهم.
- يتعلم السيطرة على سلوكه تدريجيا وحسب ما تقتضيه المواقف المختلفة.
- تتوطد علاقته أكثر مع الأبوين والأسرة من حوله والذين يهتمون به وبرعايته.
- نوبات انفعال عصبية وبكاء عند تقييد رغباته أو حركته أو فضوله في استطلاع الأشياء حوله.
- يقل الخوف من الغرباء ويبدأ الخوف من بعض الحيوانات كالكلاب.
- في نهاية السنة الثانية يستطيع تشكيل جملة من كلمتين أو ثلاثة

السنوات الثالثة ـ الخامسة من العمر (سنوات الروضة والتمهيدي)

- نمو كبير وسريع في الذكاء والقدرات العقلية والمعرفية وخاصة القدرة على الكلام من فهم وتعبير.
- زيادة القدرة على اكتساب المهارات الحرفية الدقيقة حيث يمكن للطفل في مرحلة ما قبل المدرسة إلقاء كرة فوق رأسه، أو القفز أو الوقوف على قدم واحدة لمدة 10 ثواني أو أكثر، أو رسم شخص بملامح، والاهتمام باحتياجات المرحاض، وارتداء الملابس بنفسه .
- نمو إجتماعي واضح، تقليد الآخرين في سلوكهم وتقمص طبائع وتقاليد وقيم الأبوين (بداية مرحلة تكوين الضمير وإكتساب القيم وهنا تبدو أهمية تصرف الأبوين كقدوة حسنة أمام أطفالهم).
- تكوين علاقات ودية مع الأخوة والأخوات في الأسرة ومع الأخرين.
- تستمر نوبات الإنفعال والعصبية والتوتر ولكنها تقل وتختفي نهاية العام الخامس.

- تبرز كثيراً ظاهرة الفضول وحب الإستطلاع وكثرة الأسئلة
- ينمو لديه الخيال الذي يشبع رغباته التي لا يستطيع إشباعها في الواقع ويستمتع ببعض اللعب والأشياء.
- يبدأ بتمييز هويته الجنسية كذكر أو أنثى وتمييز جنس الآخرين. كما يهتم بأعضائه الجنسية ويداعبها.
- يزداد الخوف من الحيوانات في البداية ولكن مع الوقت يتغير نحو الخوف من الأخطار الخيالية كالإشباح والوحوش.

تشمل مشاكل هذه الفترة صعوبات وإضطرابات الأكل والنوم والتعلق بالأبوين و القلق عند إبتعادهم والإنفعال الشديد عند الإحباط في الحصول على ما يريد وقد تصل حد العدوانية.

عمر السادسة ـ عشرة اعوام (عمر المدرسة)

- يستطيع تمييز هويته الجنسية ومكانه في الأسرة
- التأقلم مع محيط المدرسة وتعلم القراءة والكتابة والحساب.
- التعامل مع المعلم والمعلمة كشخصية مهمة في حياته
- يدرك ما يستطيع فعله وما لا يستطيع فعله.
- يفضل اللعب الجماعي والإختلاط مع أطفال من جنسه (الولد مع الأولاد والبنت مع البنات).
- الخوف من الأخطار الخيالية موجود ولكن الطفل يبدأ بالخوف من الموت والتفكير في معناه، وبعض الأطفال تسيطر عليهم فكرة الخوف من فقدان الأبوين مبكرا.

من أهم المشاكل في هذه المرحلة: الخوف، القلق، كوابيس النوم، بعض العلاقات المضطربة مع أقرانه، عدم الطاعة في بعض الأحيان والمشاجرات مع الآخرين.

ان النمو النفسي الطبيعي يحتاج الى:

- الصحة البدنية، التغذية الجيدة، الوقاية من الأمراض المعدية (لذا يجب الإلتزام بإكمال التلقيحات) والإكتشاف المبكر والمعالجة السريعة لأي مرض قد يؤثر في نمو الطفل مثل الفينايل كيتون يوريا، قصور الغدة الدرقية..الخ. وهذا يبين أهمية إجراء فحوص الغربلة للأمراض الأيضية.
- كما يتطلب ايضا وجود المؤثرات الخارجية المحفزة لقدرات الطفل كالتحدث معه وملاعبته وابعاده عن مصادر الأذى والإزعاج، التواصل معه، ضمه إلى الصدر، إلخ. ومن المهم أن نذكر هنا أن الطفل ليس كائناً سلبيا متلقيا فقط بل هو كائن ايجابي يتفاعل بطريقته الخاصة مع البيئة المحيطة به أثناء نموه حتى يكبر ويكون له الشكل النفسي الخاص به .
- وثمة حقيقة مهمة لابد من معرفتها وتعليمها لكل الأباء والأمهات وهي أن الأطفال الأصحاء نفسيا عادة يأتون من عوائل ودودة متحابة والتي يسودها الدفء والإحترام المتبادل بين افرادها مهما كان النمط التربوي الذي تتبعه العائلة.

فترة المراهقة (10- 19 سنة):

تُعرّف مرحلة المراهقة بأنّها مرحلة عمرية من مراحل الحياة حيث لم يعد المراهق طفلا و لم يصبح راشدا بعد ، وتِبعاً لمنظمة الصحة العالمية فإنّ المراهقة تشمل العمر 10 – 19 سنة ، و قد اختلف المختصون في تصنيف الصعوبات المرتبطة بمرحلة المراهقة ، نظرا لكونهم مجموعة غير متجانسة يختلفون فيما بينهم بسن البلوغ و مراحله و يتعرضون لعدة تغيرات و تشمل : التغيرات الجسدية و الجنسية و التطورات النفسية والاجتماعية والأخلاقية. مما يولد لديهم الشعور بالحاجة إلى الاستقلالية وتكوين الذات و الشعور بعدم الاستقرار في العائلة و اللجوء الى الاقران ليجد نفسه معهم ، و في هذه المرحلة سلوكياته تكتسب من اقرانه و تلعب البيئة التي يعيش فيها المراهق دورا مهما في سلوكياته .

من أهم مشاكل هذه الفترة العمرية الحساسية المفرطة والعناد خصوصا مع العائلة ، المزاجية ، القلق، النفور من المدرسة عند البعض، والتأثر بالاقران احيانا ، عدم الطاعة، التمرد، وفي بعض الأحيان الجنوح السلوكي (كالسرقة، العدوانية، المشاجرة، الهروب من البيت أو المدرسة، سوء إستخدام العقاقير والمواد الأخرى، الخ).

عوامل الخطورة على نمو الطفل نفسيا :

- ☒ سوء التغذية، فقر الدم
- ☒ نقص اليود
- ☒ الاختناق اثناء الولادة (حالة طبية ناجمة عن الحرمان من الاوكسجين للطفل الحديث الولادة و الذي يحدث لفترة كافية خلال عملية الولادة لالحاق الضرر الجسدي و الذي قد يؤثر على الدماغ).
- ☒ قلة وزن الوليد
- ☒ الأخماج (الالتهابات)
- ☒ الفقر
- ☒ الجهل عامة و بتنشئة الطفل خاصة
- ☒ ضعف الدعم العائلي والاجتماعي
- ☒ الاضطراب النفسي لمربي الطفل
- ☒ تلوث البيئة
- ☒ سوء الظروف المدرسية

الفصل الثالث : عوامل الخطورة والوقاية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع :

اولا: عوامل ذاتية:

1 - وجود تاريخ المرض النفسي في الأسرة.

2 - الأمراض المزمنة والوراثية.

- ✓ الاجراءات:
- ✓ تحديد نوع المرض النفسي أو العقلي أو الوراثي والتواصل مع فريق الصحة النفسية المدرسية لمعرفة الاحتمالات والآثار المتوقعة
- ✓ الاحتفاظ بملاحظات التاريخ العائلي والأسري وتحديثه دوريا
- ✓ التعرف على الوضع الصحي العام للطالب والتنسيق مع فريق الصحة النفسية المدرسية لضمان حصول الطالب على الرعاية الطبية اللازمة وقياس مدى التأقلم والتقبل وأن يكون ذلك بشكل دوري مع متابعة التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب بشكل مكثف.
- ✓ استخدام تقنيات التدريب على مواجهة الضغوط .
- ✓ تكوين مجموعات الدعم الذاتي .

3- إعاقة جسدية.

4-التمييز والتفرقة: بسبب (اللون، الجنسية، الفئة، الطبقية الاجتماعية). وجود طالب يحمل أحد هذه السمات الاجتماعية تجعله أكثر عرضه للكرب النفسي خصوصا أن هذه الضغوط مستمرة ويواجهها الطالب في الشارع والمدرسة وتتسبب في ظهور مشاعر الكره والعداء ...إلخ، ما لم يتم وضع برامج مجتمعية ومدرسية لتخفيف حدة هذه الضغوط وإدماج هذه الفئات في المحيط الاجتماعي وتكون درجة الأذى النفسي أشد وأكبر عندما يصدر التمييز من الرموز داخل البيئة المدرسية، مثل (المعلمين / المدرسين ، إدارة المدرسة) على شكل تعليقات وسخرية.

ثانيا: عوامل مرتبطة بالاسرة والبيئة:

1- الطلاق، السجن، الفقر، وفاة أحد الوالدين، وجود فوارق عمرية كبيرة بين الوالدين، تعدد الزوجات، انشغال الأبوين. وجود أي ظروف تعيق توفير البيئة الأسرية الآمنة وغياب أحد الأبوين كون الطالب لا يعيش مع الوالدين، والتي قد تظهر على شكل مظاهر الاكتئاب أو القلق أو العنف.

* **الاجراءات :**
* الحصول على معلومات كاملة عن الوضع الأسري للطالب ومعرفة مع من يسكن الطالب والتأكد من استقرار الوضع في البيئة المحيطة بالطالب.
* وضع سجل خاص يوضح هذه الفئة من الطلاب و معرفة الدخل المادي للأسر وتقديم المساعدة عن طريق الجهات المختصة .
* تدريب الطالب على مهارات مواجهة الضغوط.

2- العوامل المرتبطة بالطفولة المبكرة: تشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين تعرضوا لظروف صحية صعبة أثناء الحمل والولادة هم أكثر عرضه للاضطرابات النفسية للأطفال. كما أن الأطفال ذوي المزاج الصعب في السنوات الأولى وشديدي الحساسية وصعبي المراس أيضا أكثر عرضة لظهور الاضطرابات النفسية

- ✓ الاجراءات . تكثيف برامج التوعية والتدريب للآباء والأمهات وتزويدهم بمهارات التربية والتعامل مع الأطفال والتواصل مع مراكز الرعاية الصحية الأولية بهذا الخصوص.

3 - العنف والإيذاء على الطالب أو أحد أفراد الأسرة: وجود ضعف في مع الطفل في المراحل المبكرة ، تعرض الطالب أو أحد أفراد الأسرة لأي نوع من أنواع العنف والإيذاء النفسي، الجسدي، الجنسي يترتب عليه آثار نفسية ومختلفة تبدأ من الخوف البسيط إلى الحالات المعقدة من اضطراب ما بعد الصدمة.

- الاجراءات :
- التعرف على آثار العنف والإيذاء.
- تفعيل آلية التبليغ وفق الآلية المعتمدة.
- تدريب العاملين في البيئة المدرسية على هذه الآلية
- مهارات التدخل الطارئة في اضطرابات ما بعد الصدمة.
- التعرف على حجم المشكلة ومدى التأثر بها والظروف المحيطة بها والتعامل مع المشكلات المحيطة بها والتواصل مع أحد المراكز المتخصصة للحصول على الاستشارة والمعونة.

4-الكحول وتعاطي المواد المخدرة من قبل الطالب، او أحد أفراد الأسرة يشكل تعاطي المواد المخدرة أحد أهم الأسباب لظهور الاضطرابات النفسية وفقدان المستقبل المهني ما لم يتم التعامل معها، ويعتبر الكحول مدخلا ومؤشر لوجود مشكلات سلوكية لدى الطالب لذا يجب التعامل مع هذه الظاهرة بشكل دقيق وبذل المجهود للتخلص منها

- ✓ الاجراءات:
- ✓ تعريف الطلاب بمخاطر الكحول والمواد المخدرة.
- ✓ التعامل مع الحالات بسرية تامة.

ثالثا: عوامل مرتبطة بالعملية التعليمية:

مثل الخوف والتردد ورفض المدرسة بالنسبة للطلاب المستجدين، او ضعف التواصل بين المدرسة والمنزل. فان اثار ذلك تتمثل في:

- تأخر وضعف الدراسة، غياب متكرر، عنف واعتداء على الزملاء، هروب من المدرسة
- انسحاب وانطواء، شرود ذهني, ضعف في التركيز، إهمال النظافة الشخصية، وعدم المشاركة في الأنشطة.
- التسبب في وجود حالة مزمنة وارتباط سلبي مع البيئة المدرسية
- ضعف التواصل مع المدرسة من قبل الأسرة يشير إلى وجود مشكلة تستدعي التدخل.

- الاجراءات:
- تحديد السلوك ودراسة الأسباب والتعرف على الأوضاع المحيطة من خلال اساليب التهيئة المستخدمة لتشجيع المستجدين وإزالة الرهبة من نفوسهم.
- إيجاد وسائل مختلفة ومحفزة لزيادة التواصل مع الأسرة لضمان تبادل المعلومات عن حالة الطالب
- زيادة التفاعل والمتابعة وروح المنافسة وتعزيز الثقة لدى الطلاب.

رابعا: العوامل المرتبطة بالحوادث والأزمات

1- وجود صعوبات في الانتقال من مدرسة إلى مدرسة أخرى أو مرحلة إلى مرحلة أخرى.

2- وفاة أو فقد أحد أفراد الأسرة.

3- أزمة عاطفية أو التعرض لمواقف عصبية وخطيرة. , التعرض للاعتداء أو الاغتصاب

- ✓ الاجراءات:

- ✓ التدخل السريع في هذه الأزمات وتقديم الدعم النفسي المناسب.
- ✓ الإحالة إلى المراكز المتخصصة عند استمرار الأعراض وتطورها.
- ✓ التبليغ وفق آلية العنف والإيذاء.

خامسا: عوامل مرتبطة بالسلوك الشخصي:

1-السلوك الجنسي غير المناسب، الهوية الجنسية، التعلق .. إلخ: وجود اضطراب في النمو الجنسي والهوية الجنسية للمراهقين قد يظهر في عدة أشكال يمكن ملاحظتها من خلال الشكل العام للمراهق أو المراهقة وطريقة اللبس والكلام واستخدام بعض الأدوات غير المناسبة للجنس مع وجود دلائل أكثر خطورة تحدث بين الطلاب والتي يمكن رصدها

- ✍ الاجراءات:
- ✍ رصد الظواهر المتعلقة بالنمو العاطفي والجنسي لدى الطلاب .
- ✍ التعريف بالقضايا الجنسية والمواضيع المتعلقة بها بطريقة مناسبة ومن خلال النقاش والحوار والتعلم الذاتي.
- ✍ حصر الفئات التي يوجد لديها علامات الاضطراب الهوية الجنسية ووضع آلية لتقييم هذه الحالات ومعرفة حجم وعمق هذه المشكلة لديهم.

2- مظاهر ضعف الثقة بالنفس والرهاب الاجتماعي: ضعف المشاركة في الأنشطة والخوف والتردد، ضعف القدرةعلى التعبير عن النفس، الانزواء والانطواء، تفضيل البرامج والأنشطة الفردية

- ✓ الاجراءات.
- ✓ وضع سلسلة من برامج التعزيز والتحفيز واستغلال الأنشطة المدرسية لتعزيز الثقة بالنفس.

3- سرعة الغضب، الاندفاعية، العدوانية السلبية: وقد تتطور هذه المشكلات لتصبح نمط يصعب على الفرد معه التأقلم والعيش مع المجتمع (اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع)

- ▪ الاجراءات:
- ▪ حصر الفئة ذات المشاكل ودراسة سلوكياتها.
- ▪ تدريب الطلاب على مهارات حل المشاكل والتعامل مع الضغوط.
- ▪ الإشتراك في برامج الأنشطة الجماعية .
- ▪ تنمية روح العمل مع الفريق.

الفصل الرابع : مهارات التواصل للكوادر التدريسية والصحة النفسية للمعلم/المدرس :

التواصل : يشير الى نقل رسالة او معلومات من شخص لاخر ويشمل الاشارات المكتوبة اللفظية وغير اللفظية (حركات الجسم و ايماءات اليد و الوضعية و التواصل البصري) .

- ✓ كل كلمة، حركة، إشارة، أو ملامح الوجه هي رسالة يستقبلها الطفل ويفسرها بطريقته وتؤثر فيه, أن بعض هذه الرسائل تكون ايجابية ومفيدة وتدعم السلوك الجيد والبعض الاخر من الرسائل سلبية وضارة .

اذا تعارضت الرسالة اللفظية مع لغة الجسد فالعقل يميل الى تصديق لغة الجسد.

- ✓ **الاشياء التي من المستحسن عملها :**
- ✓ الأبتسام
- ✓ التواصل بالنظر
- ✓ كن ودودا وذا وجه مستبشر
- ✓ انظر بعيون مفتوحة (العين تتوسع برؤية الأشياء المفرحة واللطيفة).
- ✓ تكلم بشفتين مسترخيتين.
- ✓ تحرك بطريقة لطيفة وباسترخاء.
- ✓ حرك رأسك بطريقة إيجابية مشجعة
- ✓ إنحن قليلا باتجاه الطالب .
- ✓ كن فطنا .
- ✓ تفوه ببعض الأصوات المشجعة (مثلا: إمممممم، واو....)

- ☒ **الاشياء التي من المفترض تجنبها:**
- ☒ العبوس والتجهم
- ☒ التحية ببرود وبضعف
- ☒ التحديق ببرود
- ☒ النظر بنصف العين (تدل على قلة الأهتمام)
- ☒ الشرود وكأنك في عالم آخر.
- ☒ النظر بعيدا وإلى السقف وليس باتجاه الطالب
- ☒ زم الشفتين، وصك الأسنان
- ☒ القساوة، العنف والتصلب
- ☒ علامات القلق (مثل هز اليدين وارتجاف الساقين)
- ☒ التثاؤب

كيف يمكن تحسين العلاقة بين المعلم/ المدرس والطالب:

- تفعيل دور المرشد التربوي / المنسق الصحي و عدم انشغاله بمهام اخرى حيث يمارس المرشد التربوي/ المنسق الصحي المهام الأتية :
  - اولا: تحصين التلاميذ والطلبة ضد المشاكل والاضطرابات النفسية والاجتماعية لوقايتهم من الوقوع فيها من خلال تبصيرهم وتعليمهم افضل الطرق للابتعاد عنها وتلافي حدوثها .
  - ثانياً: غرس القيم الاجتماعية والمثل العليا في نفوس التلاميذ والطلبة.
- تفهم الظروف الشخصية للطلاب.
- تقبل الطلاب مهما كانوا وبكل أخطائهم، لا نتهمهم، لا نرفضهم ولا نسخر منهم.
- تشجيع السلوك الايجابي للطلاب.
- التحدث المتكرر مع الطلاب يساعد المعلم/المدرس على معرفة بماذا يفكر الطالب وكيف يفكر.
- بعض الطلاب لديهم مخاوف شديدة ولكن يصعب عليهم الحديث عن مشاعرهم وافكارهم ، قد يستمرون بالصمت بسبب الخجل أو قلة الثقة بالنفس أو الخوف من التحدث مع الكبار.
- المعلم/المدرس يتعرض لضغوط كبيرة بسبب الواجبات الكثيرة وروتين العمل المزعج والصفوف المزدحمة ولكن الاهتمام الخاص بحل مشكلة طالب معرض للخطورة سوف تنفع الطالب وتنفع المعلم/المدرس ايضاً لأنها ستبعده عن ملل العمل الروتيني كما تزيد من احترام المعلم/المدرس لنفسه .
- الحديث الى الطالب مهم جدا ولكن الأصغاء له أكثر أهمية وفائدة .
- اقناع الطالب ليفهم أن المشاركة بالمشاكل تساعد في حلها. هذا سيعلم الطلاب أن لايحصروا مشاكلهم في صدورهم بل يحاولوا حلها وأن يطلبوا مساعدة الآخرين عند الحاجة.

الفصل الخامس: مستويات التدخل والرعاية النفسية:

تتكون مستويات التداخل والرعاية النفسية من ثلاث مستويات، وهي :

المستوى الأول: تعزيز الصحة النفسية

المستوى الثاني: التداخل الوقائي

المستوى الثالث: التداخل العلاجي

المستوى الأول: تعزيز الصحة النفسية :

و ذلك من خلال تطبيق معايير المدارس المعززة للصحة النفسية .

يعتبر المعلم/ المدرس قدوة أمام طلبته، وغالبا ما يحاول الطالب أن يقلده ولذلك يعد تغيير أساليب التعامل معهم أحد وسائل تغير سلوكيات طلابنا وذلك من خلال :

- احترام الطلاب وأرائهم من خلال مساعدة الطلاب في عرض افكارهم و الانصات لهم.
- تشجيع الطالب والرفع من معنوياته حال إتقانه عملا فذلك يعزز ثقته بنفسه .
- تقديم الحوافز والمكافآت والتشجيع.
- البعد عن تقنيات الضبط السلبية، مثل العقاب، والنقد، والتهديد و تقبل الطالب كما هو.
- تدريب الطلاب على تحمل المسؤولية من خلال تكليفهم بمهام معينة يستطيعون القيام بها، وتدريبهم على التحكم في الذات والسيطرة على الانفعالات والمشاعر خاصة وقت الغضب.
- لابد للمعلم /المدرس عند حاجته للتوجيه استغلال الفرص المناسبة لقبول التوجيهات، وذلك عند أداء عمل جيد من قبل الطالب أو عند حصوله على جائزة أو عند فوزه في مسابقة وكذلك استثمار أوقات الأنشطة اللاصفية، وأوقات الفراغ لتشجيع الطلاب على التحدث عن أنفسهم والتعبير عن اهتماماتهم وطموحاتهم.
- تقديم الدعم والإرشاد اللازم لمواجهة ما يعترض الطلاب من مشكلات وأزمات شخصية سواء كانت صحية أو نفسية أو اجتماعية .
- التدخل المبكر في الأزمات الاجتماعية والنفسية، مثل مرض خطير، موت، التهجير والعنف.. إلخ.
- توفير الرعاية النفسية المناسبة و الحرص على مشاركة الطلبة في اتخاذ بعض القرارات المدرسية مثل جدول الحصص والاختبارات وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أرائهم .
- تقديم الخدمات الإرشادية المتخصصة سواء أكانت تربوية أو مهنية .
- تفعيل الأنشطة المدرسية و البرامج الترفيهية للطلبة في المناسبات المختلفة التي تحقق النمو الذاتي.
- تثقيف الطلاب حول المفاهيم الحديثة للصحة النفسية وزيادة معارفهم عن الاضطرابات النفسية والمشاكل السلوكية مما يرتقي بمعلوماتهم عن الصحة النفسية ويشجعهم.
- غرس المفاهيم الشرعية والقيم الأخلاقية و الإفصاح عن مشاكلهم النفسية والسلوكية، مما يعطي الفرصة للتدخل وعلاج هذه المشاكل مبكرا .
- تأسيس لجان مدرسية تضم مسؤول من المدرسة مع مجموعة من المعلمين والطلاب لحماية الطلاب من العنف البدني والأذى النفسي وتفعيل دورها في هذا المجال.
- التشجيع على الحوار يحسن العلاقات بين الطلاب أنفسهم من جهة وبينهم وبين إدارة المدرسة والمعلمين من الجهة الأخرى .

مهارات الحياة: تعتبر مهارات الحياة أحد وسائل تعزيز الصحة النفسية للطلاب. وهي عبارة عن السلوكيات والمهارات الشخصية والاجتماعية اللازمة للأفراد للتعامل بثقة واقتدار مع أنفسهم ومع الآخرين ومع المجتمع.

انواع مهارات الحياة :

- ❖ الابتكار
- ❖ حل المشكلات
- ❖ التفاوض
- ❖ اتخاذ القرارات
- ❖ الإدارة الذاتية
- ❖ احترام التنوع
- ❖ التعاطف والمشاركة

طرق ووسائل تعليم مهارات الحياة:

- ✓ يمكن تعليم الطلاب مهارات الحياة من قبل المعلمين/المدرسين والوالدين.
- ✓ يجب أن يكون تعليم مهارات الحياة لتعزيز الصحة النفسية بين الطلاب مبنية على أساس المشاركة والتعليم النشط مثل: (طريقة المشاركة، وطريقة التفاعل، كنقاش المجموعة، أفكار بارعة مفاجئة، لعب الأدوار، الألعاب، المناظرة، اختبارات قصيرة، صندوق الأسئلة، أداء المسرحيات ، سرد القصص ، الرسم و التلوين ...إلخ). تجنب استخدام الطريقة الإرشادية (التوجيهية)، مثل: (الأخلاقيات، والاقتراحات، والتوجيه، والإشراف)، حيث يميل الشباب إلى الرفض.
- ✓ من المهم الاعتراف بأن الأبوين والأشخاص الكبار يشكلون مصدرا هامة لضمان تطوير وتنمية المهارات بالإضافة إلى المعلم.

مجالات تنمية مهارات الحياة:

يمكن استخدام مهارات الحياة للارتقاء بسلوكيات ومهارات الطلاب في العديد من المجالات التي تهمهم مثل:

- ☙ التغذية والأمراض السارية .
- ☙ النشاط الجنسي والصحة التناسلية ، الزواج المبكر والحمل.
- ☙ الدافعية، التغيب المزمن، ومنع التسرب من المدرسة.
- ☙ تقدير الذات، والعلاقات، صورة ذاتية (فكرة المرء عن ذاته).
- ☙ المسؤولية الاجتماعية، حماية البيئة، السلام، والوئام، والمحبة
- ☙ خيار المهنة (الإرشاد المهني).
- ☙ العدوان والعنف المدرسي والشغب المتعلق بعامة الشعب.
- ☙ مشاكل الإدمان والتدخين والمشروبات الكحولية .

الأساليب التدريبية التي يتبعها المعلم/المدرس لتنمية مهارات الحياة عند الطلاب:

- ○ تعليمهم التحكم في الذات والسيطرة على الانفعالات والمشاعر و تطوير ردودهم الانفعالية والعاطفية.
- ○ التعامل بحب ومودة مع المحيطين بهم سواء في المدرسة أو البيت.
- ○ احترام الطلاب واحترام آرائهم ومواقفهم ومشاعرهم.

- مساعدتهم على حل الأزمات من خلال تعليمهم كيفية مواجهة مشاكلهم.
- تحفيزهم على العمل والإنتاج بما يتناسب مع إمكاناتهم من خلال تكليفهم بما يفضلونه ويبدعون في انجازه.
- تقدير الطلاب والثناء على أعمالهم ومواقفهم الجيدة ليشعروا بالثقة والطمأنينة ويشجعهم على تحمل المسؤولية .
- تطوير مهارات التعامل والتواصل والحوار لإنشاء علاقات إنسانية متوازنة مع الآخرين.

المستوى الثاني: التداخل الوقائي :

الدور الوقائي يكون من خلال عدة مستويات:

✓ **المستوى الأول: وهو محاولة منع حدوث المشكلة أو الاضطراب** و ذلك من خلال :

- التشخيص المبكر لمسببات القصور العقلي القابلة للعلاج، والتعرف على عيوب الحواس والإعاقة وتصحيحها، مثل (ضعف الرؤية، والسمع، وشلل الأطفال، ...إلخ).
- التدخل المبكر في الأزمات الاجتماعية والنفسية للطلاب، مثل (الإصابة بمرض خطير، أو موت شخص قريب، أو مرضه، أو طلاق أحد الوالدين، أو الكوارث، أو الهجرة، إلخ). ويكون ذلك من خلال إبعاد الطالب عن البيئة المتوترة، والإقلال من عوامل إثارة الكآبة والتحدث معه، وطمأنته، والاستماع لمعاناته، وتشجيعه على تخطي الأزمة بأقل الخسائر.
- نشر الوعي التغذوي، وتحسين العادات الغذائية، وتجنب أمراض سوء التغذية، وتأثيراتها على الصحة النفسية للطفل.
- نشر الوعي الصحي بين الطلاب عن الصحة النفسية، وأضرارها، ومتطلباتها لتهيئة مناخ نفسي صحي للطلاب لتجنيبهم الكثير من العادات السيئة، مثل: (تعاطي المسكرات، والتدخين، وإساءة استخدام الدواء).
- التعاون مع الأسرة وحث الوالدين على رعاية وتربية الأطفال تربية إسلامية، ومراقبة سلوك أبنائهم وتوجهاتهم النفسية، ولفت أنظارهم إلى خطورة العلاقات السيئة، والظروف غير المناسبة على الصحة النفسية للأبناء.

✓ **المستوى الثاني: فيشمل الاكتشاف المبكر للأمراض والاضطرابات النفسية والعاطفية والاجتماعية** عن طريق المراقبة وملاحظة تصرفات الطالب وسلوكه وردود أفعاله وتفاعله مع أقرانه ومع البيئة الاجتماعية المحيطة به والتقويم والمتابعة للعلاجات الموصوفة للمشاكل والاضطرابات النفسية المكتشفة.

✓ **المستوى الثالث: وهو محاولة تقليل الآثار السلبية الناتجة عن حدوث مشكلة او اضطراب** ، ويتضمن المساهمة والوقاية من الوقوع في المشكلات السلوكية والاضطرابات النفسية .

وذلك من خلال توعية المجتمع المدرسي بالتعرف على أسبابها ومفهومها وكيفية التغلب عليها والوقاية منها وأفضل الطرق للتعامل معها من خلال :

* توزيع مطويات على الطلاب والمعلمين.
* إشراك أولياء أمور الطلاب وتقديم المشورة للمشكلات النفسية والسلوكية ذات الأولوية.
* تقديم خدمات الاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية ونظم الإحالة.
* إقامة المؤتمرات والمعارض و مسابقات الرسم و الكتابة .

* تنظيم اللقاءات التوعوية .
* المشاركة في المناسبات العالمية، مثل:
  - اليوم العالمي للصحة النفسية
  - اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، .. إلخ .
* إجراء البحوث والدراسات العلمية، والمسوح للمشكلات النفسية المختلفة .

التداخل الوقائي للمرحلة العمرية من (3 -6) سنوات :

- العناية بصحة الطفل الجسمية والنفسية والفحص الطبي الدوري والاهتمام بتحصينه ضد الأمراض.
- الاهتمام بتغذية الطفل .
- تجنب الطفل الحوادث التي قد تؤدي إلى عاهات أو عوائق تعيق نموه.
- مساعدة الطفل في تكوين عادات نوم صحية، وعدم إرغامه على النوم.
- العمل على أن يكون الطفل سعيدا قبل ذهابه للنوم.
- معرفة أسباب فقد الشهية، أو الإفراط في الأكل لتجنبها.
- تحويل النشاط الحركي الزائد وتوجيهه للاستفادة منه.
- تشجيع الطفل أثناء لعبه ونشاطه حتى ندعم حاجته للشعور بالنجاح.
- خطورة إرهاق الطفل بنشاط حركى فوق طاقته .
- وضع الأدوية في أماكن لاتصل إليها يد الطفل .
- تشجيع الطفل على الرسم في لوحات كبيرة بغرض تعويده على مسك القلم، واستخدام المقص، والأشغال اليدوية، وإعطائه فرصة التشكيل، باستخدام طين الصلصال، وغير ذلك من المهارات التي تنمي العضلات الصغيرة لديه.
- عدم إجبار الطالب على الكتابة مبكرا قبل أن يكون مستعدا لذلك .
- مساعدة الطفل في الموائمة بين عالمه الخيالي والعالم الخارجي الواقعي.
- ملاحظة إن تشجيع الطفل يوثر في نفسه تأثيرا طيبة، ويحثه على بذل قصارى جهده.
- خطورة كبت الانفعالات، مما يهدد الصحة النفسية للطالب، والذي يؤدي به إلى انحراف سلوكه.
- مقاومة وعلاج الأمراض التي تنتشر في الطفولة المبكرة، مثل (سوء التغذية، وفقر الدم، والكساح، والإسهال، والطفيليات، والأمراض المعدية).
- تقديم الخبرات والتعليمات اللازمة للنمو الحركي السليم، وتجنب التهكم والسخرية من الطالب، إذا ما بدأت حركته غير منتظمة في بداية هذه المرحلة لان ذلك يعقد الأمور.
- تجنب القلق بخصوص استعمال الطالب يده اليسرى، وعدم إجبار الطالب الأيسر على الكتابة باليد اليمني : الالتفات إلى حالات العجز الحركي الخاصة عند بعض الطلاب، والعمل على علاجها، ومساعدة الطلاب ذوي العجز في تطور نموهم حسب إمكاناتهم.
- الاهتمام بالقصص التربوية، وتجنب المبالغة في القصص الخيالية لمنع تشويه الحقائق المحيطة به.
- الاهتمام بالإجابة عن تساؤلات الطالب بما يتناسب مع عمره العقلي، وتعليمه كيف ومتى يسأل وتدريبه على صياغة الأسئلة الجيدة.

التداخل الوقائي للمرحلة العمرية من (6 -10) سنة

- رعاية النمو الحركي لدى الطفل، وتنمية إمكانات نموه عن طريق التدريب المستمر.
- تنظيم ممارسة الألعاب الجماعية للأطفال ثقيلي الحركة .
- توعية المعلم /المدرس حتى لا يتضايق من كثرة حركة الأطفال في الفصل، فنشاطهم الحركي زائد بحكم مرحلة النمو.
- الاستفادة من رسوم الأطفال في التشخيص .
- مراعاة الفروق الفردية في قدرات الأطفال، وتكييف العمل المدرسي حسب القدرات .
- الاهتمام بقياس الذكاء وتحديد ذكاء كل طفل، ومستوى تحصيله حتى يستفاد من ذلك في تقسيم التلاميذ في صفوف المدرسة إلى جماعات متجانسة عقلية بقدر الإمكان وفي توجيههم التربوي، وإنشاء فصول خاصة لبطيئي التعلم و مدارس خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
- تشجيع الأطفال على الكلام والتحدث والتعبير الحر.
- علاج مخاوف الأطفال من خلال ربط الشيء المخيف بأشياء متعددة سارة حتى يتعود الطفل على رؤيته مقترنة بما يحب، ويسعد لرويته، وتشجيعه على اللعب مع الأطفال الذين لا يخافون نفس الشيء الذي يخافه، مع إزالة مصادرخوفه، ومساعدته على تكوين الاتجاهات، والمفاهيم السليمة التي تساعد في علاج مخاوفه.
- تجنب التركيز أكثر من اللازم على أي طالب يصدر عنه تصرف سلوكي انفعالي ما لم يقدم ويؤثر في توافقه.
- خطورة مقارنه الطالب برفاقه على مسمع منه، حتى لا يتولد لديه الشعور بالنقص.
- الحرص على جعل الجو النفسي الاجتماعي في المدرسة جو صالح خالي من التوتر.
- الاهتمام بالتربية الدينية لدى الطلاب حتى تنمي لديه هذه التربية ويستقيم سلوكه عليها.
- إشباع الحاجات النفسية لدى الطلاب خاصة الحاجة إلى الحب، والشعور بالأمن والأمان، والحاجة إلى التقدير،والانتماء إلى جماعة .
- تشجيع الهوايات وتنميتها.
- تقدير فردية واستقلال الطفل وتنمية شخصيته الاجتماعية .
- الإعداد التربوي السليم لتقبل التغيرات الجسمية التي ستطرأ على الأطفال في بداية مرحلة المراهقة.

التداخل الوقائي لمرحلة المراهقة:

- إعطاء المزيد من المعلومات الصحية الصحيحة عن تغيرات البلوغ عند الذكور والإناث.
- إعداد المراهق لكي يتقبل التغيرات الفسيولوجية المختلفة .
- توعية المراهق بمظاهر البلوغ بطريقة تربوية حتى لا يكون هناك شعور بالحرج، أو الارتباك، أو القلق، أوالخجل عندما تظهر هذه المظاهر وتبرز.
- العناية بالتغذية والنوم وتجنب الأعمال الشاقة المرهقة في هذه المرحلة بصفة خاصة .
- توجيه المراهق إلى الابتعاد عن السهر والتدخين.
- العمل على إعادة الثقة إلى نفوس المتأخرين في النضج، ولفت نظرهم إلى مبدأ الفروق الفردية في النمو مع تجنب المقارنة بينهم.

المستوى الثالث: التداخل العلاجي:

الخطوة الأولى: تحديد السلوك المحوري:

وهو السلوك الذي نريد تعديله على أن يتفق عليه المعلم/المدرس والمرشد مع الطالب والأسرة على أن يؤدي التعديل منه الى تغيرات رئيسية في السلوك بمعنى السلوك المحوري هو مصدر الشكوى .

الخطوة الثانية: قياس مقدار شيوع السلوك

وهي جمع بيانات وملاحظات عن عدد تكرار ظهور السلوك.

الخطوة الثالثة: المظاهر السلوكية السابقة للمشكلة واللاحقة لها

وهو التحديد الدقيق للظروف السابقة والمحيطة بالطفل عند ظهور السلوك غير المرغوب به، كالطفل الذي يعتدي على زميله بالفصل الدراسي في الأوقات التي يكون بها المعلم/ المدرس مشغولا مع زملائه، حيث تتطلب هذه الخطوة اكتشاف بداية ظهور هذه السلوك من خلال دراسة حالة الطفل.

الخطوة الرابعة: وصف الخطة العلاجية

و تشمل كل الأساليب الفنية التي تستخدم لتدعيم ظهور السلوك المرغوب وإيقاف السلوك غير المرغوب به، كأن يستخدم المعلم/المدرس طريقة الإبعاد المؤقت إذا بدء الطفل في نوبات الغضب والاعتداء، كما تشمل الخطة العلاجية جدول زمني محدد لتقييم برنامج العلاج ومدى تحقيق أهدافها. وتتضمن الخطة العلاجية الأهداف التالية :

- تشجيع الاتجاه الإيجابي لدى الأطفال، والعمل على ابتكار شروط تساعد على ظهور أنواع السلوك الإيجابية المرغوب فيها بدلا من التركيز على مراقبة الأطفال وعقاب سلوكياتهم غير المرغوب بها.
- مساعدة الطفل على ابتكار وممارسة نماذج سلوكية معارضة للسلوك الخاطئ .
- الاحتفاظ بسجل يومي للتقدم أو تعديل السلوك.
- إدماج أولياء الأمور والمعلمين وزملاء الصف في خطة تعديل السلوك.

الخطوة الخامسة: النتيجة :

وهي الخطوة التي تتعلق بتطورات الحالة أثناء تنفيذ الخطة العلاجية، وهذه التطورات تكون كالتالي تحسن بدرجة (*مقبول، *جيد، *ممتاز) ،عندما يطرأ تحسن ففي هذه الحالة يتم إعادة تقييم للحالة ، واتخاذ الخطوات المناسبة في ضوء التقييم الجديد .

الفصل السادس: المشكلات النفسية الأكثر شيوعا عند الأطفال واليافعين و عوامل الخطورة لها والوقاية منها:

حقائق رئيسية

على الصعيد العالمي، يعاني واحد من كل سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاماً من اضطراب نفسي، وهو ما يمثل 13 في المائة من العبء العالمي للمرض في هذه الفئة العمرية.

إن الاكتئاب والقلق والاضطرابات السلوكية هي من بين الأسباب الرئيسية المؤدية إلى المراضة والإعاقة في صفوف المراهقين.

الانتحار هو السبب الرئيسي الرابع للوفاة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً.

تمتد عواقب عدم معالجة اعتلالات الصحة النفسية لدى لمراهقين إلى مرحلة البلوغ، وهو ما يتسبب في ضعف الصحة البدنية والنفسية على السواء ويحد من فرص التمتع بحياة مرضية في مرحلة البلوغ.

اولا : الاضطرابات العاطفية:

وهي نوعان:

النوع الأول: المشابهة للكبار مثل (القلق او الاكتئاب او اضطراب الكرب مابعد الصدمة).

النوع الثاني : اضطرابات عاطفية خاصة بالاطفال و اهمها التبول اللاارادي الليلي .

اضطراب القلق العام: اهم الخصائص التشخيصية: إذا شكا المريض من أحد الأعراض التالية عدة مرات في الشهر وبشكل مستمر.

- شعور مستمر بالخوف وبالتوتر وعدم الاستقرار بدون سبب واضح
- (النرفزة) الغضب لأتفه الأسباب
- (الجفلة) فرط الاستجابة للمنبهات الخارجية
- النسيان وعدم التركيز
- الهوس بالمثالية
- عدم الثقة في النفس
- تجنب الذهاب الى المدرسة او تجنب المواقف الاجتماعية
- اعراض موجودة في حالات القلق والاكتئاب معا: مثل اضطرابات في النوم أو في الأكل واعراض جسدية مختلفة صداع، دوخة، شحوب، جفاف الفم، الشعور بصعوبة البلع، آلام البطن، إسهال، الشعور بالاختناق، خفقان، آلام عامة، آلام المفاصل، ارتجاف الأطراف، اضطراب الدورة الشهرية..... والخ).

كيفية التعامل مع حالات القلق:

* هدئ من خوف الطالب.
* عمل كشف للأعراض التي يذكرها لطمأنته.
* الخوف قد يزول مع جعل الطالب يشرح ما يشعر به .

* إعطاء الطالب الدعم النفسي الإيجابي من قبل الأسرة والمدرسة، وتجنب أسلوب الترهيب من الامتحانات الدراسية .
* تشجيع الطالب على ممارسة الأنشطة والهوايات.
* إحالة الطالب الى المركز الصحي في حال عدم استجابته.

اضطراب الاكتئاب المعتدل الى الحاد: اهم الخصائص التشخيصية:

- الشعور بالحزن ومزاج مكتئب مستمر، خاصة في الصباح عنه في المساء.

فقدان الاهتمام والاستمتاع بالأنشطة اليومية التي يمارسها الطالب. وعدم الشعور بلذة الحياة

- قلة الحركة وسرعة التعب وقلة التركيز.
- كثرة الغياب من المدرسة، أو تدهور واضح في أدائه الدراسي.
- العزلة الاجتماعية والشعور بالذنب وتقليل القيمة الاعتبارية للفرد نفسه.
- اللجوء إلى المخدرات في مرحلة المراهقة
- أفكار متكررة في رغبة الموت أو الانتحار.
- اعراض موجودة في حالات القلق والاكتئاب معا: مثل اضطرابات في النوم أو في الأكل واعراض جسدية مختلفة (صداع، دوخة، شحوب، جفاف الفم، الشعور بصعوبة البلع، آلام البطن، إسهال، الشعور بالاختناق، خفقان، آلام عامة، آلام المفاصل، ارتجاف الأطراف، اضطراب الدورة الشهرية.... والخ).

يجب ان تكون هذه الاعراض مستمرة لمدة اسبوعين او اكثر .

كيفية التعامل مع الطالب المكتئب:

- الحديث بصراحة مع الطالب وتشجيعه للتعبير عن مشاعره.
- أسأل الطالب عن أي تغير حدث بالنسبة للأسرة، وعن أية مشاكل عاطفية او اجتماعية او اقتصادية .
- لابد من وجود دعم للطالب من الأسرة والمدرسة، ومحاولة مساندته في المدرسة .
- محاولة دمج الطالب في أنشطة مختلفة وإعطائه دور في هذه الأنشطة .
- الاستمرار في التشجيع والدعم و نصح الأسرة بأخذ المشورة من متخصص.
- الإحالة إلى المركز الصحي (وحدة الصحة النفس - اجتماعية) لتدبير الحالة.

الخوف من المدرسة:

يعرف الخوف من المدرسة بأنه حالة من الاضطراب تظهر على سلوك الطالب قبيل ذهابه إلى المدرسة، يصاحبها نوع من القلق العاطفي والرغبة في الجلوس في البيت تحت علم ومراقبة الوالدين، علما بان هؤلاء الأطفال عادة لا يعانون من أي مشكلات اجتماعية. وإنها تواجه عدد كبير من الطلاب.

تمثل تجربة المدرسة بيئة جديدة على الطفل حيث يستوجب عليه إتباع سلوك جديد و الانصياع تحت أوامر جديدة، فتكون ردة الفعل اما بشكل مباشر بالتنحي وتجنب الذهاب إلى المدرسة، أو على شكل أعراض فيزيائية للقلق، والتي تظهر بصفه خاصة في الصباح عندما يتم حثه على الذهاب إلى المدرسة، وتشتمل هذه الأعراض، مثل(:الغثيان، القيء، الصداع، الإسهال، الشكوى من الم البطن، التهاب الحلق، وآلام الساقين،... إلخ)، ويمكن ملاحظة الصعوبات التي تتعلق بالأكل واضطراب النوم ومخاوف أخرى متباينة، وقد تزيد شكوى الطالب من قلق والديه عليه.

لذلك يستوجب تهيئة الطالب نفسيا للتعامل مع التغيير الكبير في نظام حياته نتيجة لالتحاقه بالمدرسة قبل بدء الدراسة بفترة.

كيفية التعامل مع حالات الخوف من المدرسة:

- التأكيد على دور المدرسة في الاهتمام بالأسبوع التمهيدي والاستقبال الحسن للطالب بوجه بشوش مرح وتوزيع الهدايا الرمزية و التجول به خارج الفصل للتكيف والتأقلم مع الجو العام للمدرسة، والأخذ بتوجيهات المختص النفسي في حالة تحويل الطالب للجهات الصحية النفسية.
- تقبل وتفهم مشاعر الطالب كمشاعر حقيقية وموجودة، ومساعدته على اكتشاف أساليب لزيادة قدرته في التحكم بهذه المشاعر السلبية، وتجنب استخدام القسوة لاجباره على الذهاب الى المدرسة او اتهامه بالضعف والجبن
- دور الأسرة في علاج هذه الحالات بتبصير الوالدين بطرق التعامل مع الطالب، والتغلب على الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه الحالة.
- الانتباه للمكاسب الثانوية لسلوك الخوف من المدرسة، مثل: (الحصول على انتباه الوالدين، البقاء بالمنزل واللعب، أو حصوله على مغريات وجوائز في حالة ذهابه للمدرسة).
- ضرورة الحزم في أهمية الذهاب للمدرسة، وعدم السماح للطالب أن يختار عدم الذهاب للمدرسة بسبب القلق، خصوصا إذا لم يكن مصدر قلقه هو خوفه من التعرض لعنف أو تهديد بالمدرسة .
- التأكيد على أهمية الزيارات الدورية من قبل الأم للمدرسة ومتابعة حالة الطالب، والتأكيد على دور المرشد التربوي كهمزة وصل بين المدرسة من جهة والأسرة من جهة أخرى.
- اللجوء للمعالج النفسي لوضع خطة للعلاج السلوكي باستخدام استراتيجية التعرض التدريجي لموقف الخوف متدرجة من الأسهل إلى الأصعب.

اضطراب الكرب مابعد الصدمة: أهم الأعراض التشخيصية:

- تعرض الشخص لحادث صادم
- ردود الأفعال الحادث الصادم تستمر لأكثر من شهر الى ستة أشهر وقد تظهر لاحقا.
- نوبات استذكار للحادث الصدمي مصحوبة بانفعالات شديدة مشابهة للتي حدثت اثناءه. (Flash back)
- تجاهل وتجنب لكل ما يذكره بالحادث أو يدل عليه. (Avoidance) .
- الاستثارة المتزايدة وأحيانا نوبات من الذعر أو العدوانية.
- تدهور شديد في الأنشطة الوظيفية والاجتماعية .

كيفية التعامل مع حالات الكرب مابعد الصدمة:

- عمل كشف للأعراض التي يذكرها الطالب لطمأنته.
- قلل من مخاوف الطالب .
- الخوف قد يزول مع جعل الطالب يشرح ما يشعر به.
- إعطاء الطالب الدعم النفسي الإيجابي من قبل الأسرة والمدرسة.
- تشجيع الطالب على ممارسة الأنشطة والهوايات.
- إحالة الطالب إلى المركز الصحي في حال عدم استجابته.
- ممكن الاستعانة بمختصين في مجال الصحة النفسية أن تطلب الأمر.

الاضطرابات الذهانية مثل الفصام: اهم الخصائص التشخيصية:

- فقدان البصيرة بحالته الصحية

- هلاوس (سمعية، بصرية، ذوقية، حسية، او شميه)
- اوهام (افكار خاطئة وراسخة لا تتزحزح) ,
- تدهور شديد في الأداء الوظيفي والمجتمعي.

كيفية التعامل مع الاضطرابات الذهانية:

إحالة الطالب إلى المركز الصحي.

النوع الثاني: اضطرابات عاطفية خاصة بالاطفال واهمها التبول اللاارادي الليلي:

هو عبارة عن عدم القدرة في التحكم بالمثانة أثناء الليل على الأقل مرتين أسبوعيا، لفترة مستمرة لا تقل عن 3 شهر، حيث يعد الطفل الذي لا يتحكم في مثانته أثناء الليل لمرة أو عدة مرات متعددة بأنه يعاني من التبول اللاإرادي الليلي. يصيب حوالي 10% من الأطفال، الذكور أكثر من الإناث. ويتم تشخيصه بعد السنة الرابعة من العمر وقد يرافقه بعض الاضطرابات العاطفية والسلوكية أو النمائية للاطفال مثل تأخر النطق، المشي والفشل المدرسي.. الخ. وهو نوعان (طفل لم يتحكم بالمثانة منذ ولادته حتى العام الخامس من العمر) يسمى تبول لا إرادي أولي. وطفل يتحكم بالمثانة لفترة لا تقل عن ستة أشهر ثم أصبح لا يتحكم في المثانة) يسمى تبول لا إرادي ثانوي.

كيفية التعامل مع التبول اللاإرادي الليلي:

إذا لم يتحكم الطفل إطلاقا في المثانة منذ ولادته فالاغلب سبب عضوي: يحال إلى المركز الصحي لمعرفة السبب.

وفي حالة التبول اللاإرادي الثانوي فيجب القيام بالتالي: اعطاء ارشادات للطالب والام .

الارشادات هي: (شجع الطفل أن ينظف سريره بنفسه في حالة البلل، أعطي مكافأة على اليوم الذي يكون فيه الفراش جاف ونظيف، شجع الطفل أن يذهب إلى الحمام قبل النوم، على الوالدين إيقاظ الطفل لتفريغ المثانة مرة ثانية قبل أن يناموا، عدم استخدام العقاب اللفظي مثل: إهانة الطفل، أو إطلاق بعض المسميات عليه خاصة من أخوته، لا تستخدم الضرب كعقاب على بلل الفراش، لا تشجع إعطاء سوائل كثيرة خلال النصف الثاني من النهار خاصة المواد المدرة للبول، مثل: الكولا، أو الشاي، أو القهوة).

متابعة الارشادات لفترة لاتقل عن شهرين فان لم توجد استجابة، يحال إلى المركز الصحي لمعرفة السبب.

ثانيا: الاضطرابات السلوكية:

فرط الحركة وتشتت الانتباه: علاماته التشخيصية:

- تبدأ الأعراض بالظهور قبل سن 7 سنوات ولستة اشهر على الأقل ، وأغلبه عند الذكور ويقل مع تقدم عمر الطفل .
- الحركة الزائدة: مثلا لا يقدر أن يجلس على كرسي طوال حصة كاملة، الثرثرة، ومقاطعة الآخرين مما يسبب مشكلات في التعلم والدراسة.
- صعوبة التركيز وتشتت الانتباه: لا يستطيع إنجاز ما يبدأ به .
- سهولة الالتهاء عن الواجب التململ, وقلة النظام.
- الاندفاعية واللاأبالية: يفعل أشياء فجأة من دون التفكير فيها مما يسبب تحطيم ألاشياء في المنزل بدون قصد وعدم القدرة على انتظار دوره في لعبة ما أو الإفراط في الحديث أو إحداث ضجة .
- ويجب أن تلاحظ الأعراض في مكانين مختلفين على الأقل (مثلا في البيت والمدرسة او غيرها).

ما هو دور المعلم في الصف تجاه الطفل صاحب اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه:

- تجاهل بعض السلوكيات التي بها اندفاعية وعدوانية بسيطة في الصف .
- تشجيع سلوك الطفل الجيد بدلا من استخدام العقاب عند حدوث السلوك غير المقبول .

- تقسيم الأعمال المطلوبة على الطفل إلى أجزاء مصغرة مع الثناء في حال تم الانتهاء من الجزء المطلوب في الوقت المناسب .
- وضع الطفل في صف قليل العدد مع الحفاظ على عدم وضع المثيرات المشتتة للانتباه، مثل اللوحات الإرشادية والفصلية، الإنارة الزائدة، أشعة الشمس الكثيفة،... إلخ.)
- السماح للطالب بالحركة بين الحصص.
- التعاون بين المدرسة والأسرة في متابعة سلوكيات هذا الطفل واستخدام الإثابة.

الأساليب العلاجية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه:

تنوعت وتعددت الأساليب العلاجية المستخدمة لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، مثل :

العلاج الطبي: يعتبر من أكثر الطرق العلاجية شيوعا واستخداما في علاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بالأدوية والعقاقير الطبية حيث تقلل من النشاط الحركي للطفل، وتحسن من مستوى انتباهه، وتقلل من شرود الذهن والاندفاعية ويحسن من أدائه المدرسي.

العلاج السلوكي: يعتبر من الأساليب العلاجية الناجحة والفعالة في علاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، حيث يقوم هذا النوع من العلاج على نظرية التعلم من خلال تحديد المعالج للسلوكيات غير المرغوب بها لدى الطفل، وتعديلها بسلوكيات أخرى مرغوب بها، وتدريب الطفل عليها في مواقف تعليمية، إذ يهدف العلاج السلوكي على مساعدة الطفل في التعامل من تلقاء نفسه مع المواقف، أو المشكلات التي يمكن أن تواجهه، من خلال تدريبه على استراتيجيات التعامل مع الآخرين، ومع الواجبات المطلوبة منه، وذلك بواسطة معالج سلوكي مؤهل.

العلاج السلوكي المعرفي: يهدف هذا النوع من العلاج إلى خفض المظاهر السلوكية التي يقوم بها الأطفال ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وتقليل الآثار السلبية لها ، والمعتمد على تقييم الطبيب والباحث النفسي.

الاضطراب السلوكي العدواني

اهم خصائصه التشخيصية: تقع في أربع فئات :

- العدوان على الناس الحيوانات: (مستويات مفرطة من العراك أو التنمر)، (القسوة مع الحيوانات)، (السلوك الاستفزازي والمتحدي ونوبات غضب حادة ومتكررة).
- تدمير الممتلكات واشعال النيران.
- الغش والكذب أو السرقة وتناول الكحول او المخدرات.
- انتهاك خطير للقواعد (العصيان، التغيب عن المدرسة، الهروب من المدرسة)

ملاحظة مهمة:

- حصول المرض في طفل لا يتميز بالعدوانية سابقا، فقد يكون ناتج عن اصابته بالاضطرابات العاطفية مثل الكآبة أو القلق او الامراض العصابية الأخرى.
- الجنوح في المراهقة يكون مسبوقا باضطراب السلوك في الطفولة وبعلاقات عائلية تتسم بالاضطراب والعدوانية وبفقدان أحد أو كلا الأبوين، وقد يكون أحد الأبوين مضطربا نفسيا.

العوامل المساعدة في التخلص من السلوك العدواني:

- ❖ تحديد أسباب العدوان ومحاولة تجنبها، كالتقليل من تعرض الطفل لنماذج العدوان التليفزيونية .
- ❖ تجنب أساليب المعاملة الوالدية الخاطئة، وذلك من خلال برامج توعوية تقدم للأسرة.

- ❖ تعليم الطفل المهارات السلوكية والاجتماعية السليمة، كبدائل للسلوكيات العدوانية.
- ❖ تشجيع الطالب على التنفيس الانفعالي المتزن، وضبط مشاعره، والتحكم بها أثناء تفاعله مع الآخرين.
- ❖ تعزيز وإثابة السلوك المسالم والمرغوب .
- ❖ توجيه الطالب لتعلم طرق بديلة للتخلص من الغضب، مثل (اللعب، وممارسة الرياضة، والاشتراك في الأنشطة).
- ❖ تعليم الطفل كيفية التعامل مع المواقف المحبطة في الحياة.

ثالثا: الاضطرابات النمائية الشاملة: اضطراب طيف التوحد

يتم تحديد الطفل الذي يعاني من تأخر في النماء من خلال مقارنة سمات نمو الطفل مع أطفال آخرين من نفس العمر في نفس البلد. (تحديد العمر الذي بدأ فيه الطفل بالابتسام، الجلوس، الوقوف بنفسه، المشي، الكلام، فهم التعليمات، التواصل مع الآخرين) او استخدام مقايس النماء المحلية أما بالنسبة للأطفال الكبار: نستخدم كل ما ذكر سابقا بالإضافة إلى ملاحظة مدى قدرتهم على القيام بالواجبات المدرسية أو الأنشطة المنزلية اليومية .

الخصائص التشخيصية لاضطراب طيف التوحد:

- **صعوبات في التواصل الاجتماعي والتفاعل العاطفي:** ومن علاماته تجنب النظر في عيون الآخرين، وعدم إظهار الفرح أو السعادة عند ملاطفته أو حمله ومداعبته والمرح مع الآخرين.
- **صعوبات في التواصل اللغوي:** حيث لا يمتلك أية قدرة على الكلام أو أنه يتكلم بشكل غير طبيعي مثل تكرار ما يقال أمامه بشكل ببغائي أو استعمال الضمائر بشكل معكوس.
- **يؤدي حركات غير طبيعية:** حيث تكون حركاتهم خرقاء وغير هادفة ومكررة .
- يتعاملون مع الأشخاص وكأنهم أشياء (يمسك بيد أمه ليحرك بها كرته وكأن يد أمه عصا).
- يهتمون بأجزاء صغيرة من ألعابهم ويحطمون باقي أجزاء اللعبة .
- يقومون بحركة ثابتة لفترة طويلة (إغلاق وفتح الباب لمدة طويلة بدون ملل).
- الإصرار على طقوس معينة مثل الكيفية التي يقدم بها طعامه أو الإصرار على وجود أشياء معينة وعند تغييرأي من هذه الطقوس يغضب ويحتج بعنف .
- **يشخص بعمر ثلاث سنوات فأكثر وينمو جسديا بشكل طبيعي** وقد يترافق هذا المرض بنوبات الصرع او بحالات التاخر العقلي.
- **الاجراءات:**

- تسجيل الطفل في مركز أو مدرسة خاصة للتوحد، والحرص في المداومة على تتبع الطفل وزيارته بالمدرسة ، ويجب اتباع نمط واحد في التعامل مع الطفل في المدرسة أو البيت.
- مراعاة الحالة النفسية للطفل، فعلى المعلم معرفة ما يسعده وما يحزنه والحرص على عدم إبقائه وحيدا لفترة طويلة، والتكلم معه عما يدور في داخله .
- الحرص على جعل الطفل يتواصل مع من حوله، وأن يكون التواصل بصريا ولفظيا، وتشجيعه على ذلك، وتحفيزه بالهدايا وعلى أن يتكلم ويطلب ما يريد.
- جعل الطفل يتواصل ويلعب مع الأطفال من عمره؛ فأطفال التوحد يفضلون التعامل مع الكبار.
- منع الطفل وشغله عن الحركة النمطية ومعاقبته كلما فعلها؛ حيث إن لكل طفل حركة نمطية يقوم بها عند الانزعاج من شيء.
- تشجيع الطفل على القيام بعمل أو مبادرة وزرع الثقة به، وتشجيعه للاعتماد على نفسه .

- العمل على تعليم الطفل مصادر الخطر وتدريبه على الدفاع عن نفسه.
- تدريب الطفل على اللعب لتفريغ الطاقة ولتفريغ الاضطرابات، وتعليمه كيفية الاستمتاع باللعب، ويفضل مشاركة الأم لطفلها في اللعب حتى يحب ذلك .
- تدريب الطفل على عدم اتباع روتين معين، وتقبل التغير، وكيفية التعامل معه والتعامل مع الواقع كما هو، وتعليم الطفل كيف يقوم بالأعمال الموكلة إليه .

رابعا: مشاكل معرفية:

بطء التعلم:

هو ضعف عام في القدرة العقلية للطالب لا يصل إلى درجة الإعاقة العقلية، وتتراوح نسبة ذكاء هذه الفئة ما بين (٧٠-٩٠) درجة، مع انخفاض واضح في التحصيل الدراسي في جميع المواد الدراسية، ومن أسباب بطء التعلم في المراحل الدراسية، ما يلي:

أسباب عضوية: مثل (مشاكل في السمع، مشاكل في النظر، نوبات صرع صغرى، سوء التغذية).

أسباب اجتماعية: مثل (ضعف الحالة المادية كالفقر، الحرمان الاجتماعي، الأسرة كبيرة العدد، البيئة المدرسية الطاردة).

أسباب نفسية: مثل (مشاكل انفعالية كالقلق والاكتئاب والرهاب الاجتماعي، مشاكل سلوكية كفرط الحركة وتشتت الانتباه، مشاكل في النمو، كالإعاقات العقلية، صعوبات التعلم كعدم القدرة على تعلم القراءة والكتابة والحساب).

دور المعلم/المدرس تجاه الطالب بطيء التعلم في المدرسة :

لابد من المعلم/المدرس الاهتمام بالطالب للحصول على الجهد المبذول لتعلم الدرس المطلوب، حيث يتطلب من المعلم تشجيعه وتدعيمه واستخدام أفضل السبل والطرق لتفادي الإحباط وما سينتج عن ذلك من سلوكيات غير مقبولة، كالسلس البولي، والعدوانية، وفقدان الاهتمام، وعدم الرغبة في التعليم، ..إلخ

تطبيق مهارات التدريب الناجح لطفل بطيء التعلم:

- ✓ كتقسيم كل نشاط تدريبي إلى خطوات ومراحل صغيرة مع شرحها بوضوح والاستعانة بالأمثلة
- ✓ إعطاء بطيء التعلم تدريباً متكررا في كل نشاط
- ✓ مكافأة الطالب على المحاولة والخطأ.
- ✓ تقليل المكافآت بالتدريج فيما بين كل مهارة يبرع بها ومهارة أخرى يرتقي لها.
- ✓ استخدام أدوات التدريب الملائمة والجذابة والمتوفرة محليا .

التأخر الدراسي:

يعرف التأخر الدراسي بأنه عبارة عن حالة من التأخر والتخلف والنقص نتيجة لعوامل عقلية أو جسمية أو اجتماعية أو انفعالية، بحيث تنخفض نسبة التحصيل الدراسي دون المستوى العادي والمتوسط).

حيث يؤدي التأخر الدراسي الى أثر سلبي كبير على الطالب، كانخفاض الدافعية والعزلة والشعور بالإحباط، وعدم الثقة بالنفس، وبالتالي يؤثر ذلك على صحة الطالب النفسية ، ويمكن تشخيص ظاهرة التأخر الدراسي من خلال (قياس الذكاء، قياس المستوى التحصيلي، أخذ آراء المعلمين والأخصائيين في المدرسة والوالدين، التعرف على العامل البيئي والصحي للطالب).

ويتمثل علاج التأخر الدراسي من خلال ما يلي:

- التعرف على أسباب التأخر الدراسي.
- وضع خطة علاج يقوم على تنفيذها المعلم/المدرس مع إدارة المدرسة والمرشد التربوي.

- الاهتمام بأوجه القصور الصحي وعلاجها بالتعاون مع الوالدين.

اضطراب الكلام (التأتأة):

تعتبر التأتأة من المشاكل اللغوية التي تحدث لدى الأطفال، وتؤثر على طلاقة الكلمات عند حديثهم وتواصلهم مع الآخرين، وقد تكون على شكل ترديد للكلمات في البداية أو وسط الكلمة أو السكوت فجأة أثناء الحديث، وأحيانا تكون هذه المشكلة شديدة لدرجة أنها تؤثر على الناحية التعليمية والاجتماعية للطفل، إذ تمثل نسبة التأتأة لدى الأطفال (1%), حيث تكثر لدى الذكور منها لدى الإناث بنسبة (1:4) وتكثر هذه المشكلة في العائلات التي يكون بها تاريخ وراثي، أو بسبب وجود صراع أو خوف وقلق لدى الطفل، حيث تصبح بشكل أكبر في حال وجود ضغوط نفسية في بيئة الطفل.

النصائح المهمة في علاج والتقليل من أثار التأتأة ما يلي:

- عدم استخدام الشدة والعنف والتوبيخ مع الطفل.
- تنبيه المعلمين وأولياء الأمور بعدم التعرض للطفل بالتعليق والاستهزاء بالمدرسة .
- تشجيع الطفل على الكلام باستمرار وتجاهل التأتأة التي يتعرض لها.
- عمل الجلسات العلاجية الفردية مع الطفل يوميا لمدة نصف ساعة على الأقل من خلال تدريبه على بدء الحديث بهدوء وتخفيض سرعة الكلام والتوقف بين الجمل.
- إشراك أخصائي النطق والتخاطب في العملية العلاجية .
- استخدام الأساليب المعززة والمشجعة أثناء العملية العلاجية .

التنمر المدرسي :

التنمر هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل أو مجموعة من الأطفال فيكون (متنمر)ضد طفل أخر (المتنمر عليه) أو إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة.

ما هي أنواع التنمر المدرسي ؟



- بدني، مثل: الضرب، أو اللكم، أو الركل، أو سرقة وإتلاف الأغراض.
- لفظي، مثل: الشتائم، والتحقير، والسخرية، وإطلاق الألقاب، والتهديد.

- اجتماعي، مثل: تجاهل أو إهمال الطفل بطريقة متعمدة، أو استبعاده، أو نشر شائعات تخصه.
- نفسي، مثل: النظرات السيئة، والتربص، التلاعب وإشعار الطفل بأن التنمر من نسج خياله.
- إلكتروني، مثل: السخرية والتهديد عن طريق الإنترنت عبر الرسائل الإلكترونية، أو الرسائل النصية، أو المواقع الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي، أو أن يتم اختراق الحساب .

دور المعلم/المدرس عند حدوث التنمر :

* إذا شاهد المعلم أو نُقلت إليه حادثة تنمر في أي مكان داخل المدرسة وجب عليه التحرك فورًا بمفرده أو بصحبة معلمين آخرين للفصل بين التلاميذ والتأكد من سلامة الجميع وعدم تجدد الاشتباك مرة أخرى.
* كما لا بد أن يُظهر المعلم سيطرة حقيقية تردع المشاغبين عن الاستمرار(المتنمر و مجموعته)، وتُطمئن الطلاب الضحايا والآخرين المتفرجين، إذ إنه من الضروري أن يشعر التلاميذ أن معلميهم /مدرسيهم يملكون حلولًا لمشكلة التنمر.
* في نفس الوقت، يجب على المعلم /المدرس الحرص على عدم إيذاء الطفل او اليافع المُعتدِ وأن يتجنب إظهار سلوكيات عدوانية تجاه المتنمرين؛ حتى لا يُحسب ذلك تنمرًا من ناحيته فيقدم قدوة سيئة لطلابه. لذلك يجب أن يتعامل المعلم بحزم دون أن يتصرف تصرفات غير لائقة.

دور المعلم/المدرس مع الطالب ضحية التنمر :

- يحتاج الطالب ضحية التنمر إلى معاملة تراعي احتياجاته النفسية فقد يغلب عليه لحظة التنمّر شعور بالمهانة والضعف.
- وهنا يظهر دور المعلم/المدرس الواعي الذي يُشعر الضحية بالتقدير وبأن الأمر سيؤخذ على محمل الجدّ. لذلك يجب أن ينصت المعلم إلى الطالب بتركيز دون أن يحاول لومه على مشاعره أو حتى تعديلها وإنما عليه فقط إظهار التفهم الكامل لها.
- ثم يأتي بعد ذلك دور بث الطمأنينة في نفسه الخائفة المذعورة والتأكيد على أن الطفل الآخر قد أخطأ في حقه وسوف تقوم الإدارة بدورها في ضبطه.
- رفع الوعي حول التنمر وأدواته. ومن ذلك إخبار الطالب أن غاية المتنمر أن يرى نظرات الخوف في نظر ضحاياه. بالإضافة الى إمداد الطفل بالكيفية الصحيحة للدفاع عن النفس والرد على المتنمر.
- عقد جلسات مع الطفل لبحث أسباب المشكلة وطرق التخلص منها ولدفعه إلى مصارحة والديه وأسرته.
- وتستمر متابعة المعلم /المدرس للمشكلة مع الطفل ليعلِمه بالإجراءات التي قامت بها المدرسة تجاه المتنمر واعوانه وللتأكيد على أن السلوكيات المؤذية غير مرحب بها.

دور المعلم/المدرس مع الطفل المتنمر :

- المتنمر هو ضحية أيضًا لظروف نفسية أو اجتماعية. ومن هنا فعلى المعلم/المدرس أن يمنح المتنمر الفرصة الكاملة لرواية قصته ثم التثبت منها، فإذا كان الطفل مدانًا يقوم المعلم بشرح الخطأ له وإخباره أن هذه النوعية من التصرفات غير مقبولة تمامًا.

- لاحقًا، يعقِد المعلم/المدرس جلسات مع الطفل المتنمر لمناقشة الأسباب التي دفعته لمثل هذه التصرفات ويضع له خطة تحفيزية تشجعه على التخلي عن التنمر وترشده إلى الوسائل السليمة لتحقيق أهدافه. فإذا كان يطمح مثلًا إلى الزعامة يمكن إرشاده إلى المشاركة في الأنشطة المدرسية والانتخابات الداخلية.
- ومن الضروري ربط نظام المكافآت المدرسية بتعديل السلوك، فلا يحصل الطالب على حصته من الأنشطة الترفيهية كالرحلات قبل أن يعدل سلوكياته الخاطئة.
- التواصل مع الأسرة وإجراء التدخل اللازم لمعالجة الأساليب التربوية والمشاكل الأسرية التي قد تكون الشعلة التي تولد منها لهيب التنمر.

نظام الاحالة بالنسبة للطلبة المشاكسين :

المدرسة ← المركز الصحي ← خدمات تخصصية ← نظام متابعة

المدرسة

- ✓ الادارة ومرشد الصف والكادر التربوي
- ✓ المرشد التربوي او المنسق الصحي

المركز الصحي

- ✓ وحدة الصحة المدرسية
- ✓ وحدة الصحة النفس اجتماعية

خدمات تخصصية

- ✓ مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية و بعد فحص الحدث بدنيا و عقليا و نفسيا ينظم المكتب تقريراً مفصلاً عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية واسباب تعرضه للجنوح والمقترحات التي يوصي بها ادارة المدرسة او اي جهة اخرى لمعالجته ولرعايته.
- ✓ اللجان الطبية والعيادات النفسية المتخصصة.

دور الاسرة في الرعاية الصحية النفسية :

الاسرة اللبنة الاولى في بناء المجتمع و يمكن القول بأن للاسرة دورا كبيرا في رعاية الاولاد (منذولادتهم) و في تشكيل اخلاقهم و سلوكهم حيث اهمال تربية الابناء جريمة يترتب عليها اوخم العواقب و ان انحرافات الاسرة من اخطر الامور التي تولد انحراف الابناء فالتوجيه يبدأ في نطاق الاسرة اولا ثم المدرسة و المجتمع حيث ان المعاملة المعتدلة تعتمد على المزج بين العقل والعواطف، وتوجيه النصح والإرشاد، وبهذا تتكون شخصية سليمة وصحيحة، وإذا لم يستجب الأولاد بالإرشاد والتوجيه يلجأ الأبوان إلى توبيخهم ثم هجرهم ثم حرمانهم من بعض الأشياء والأمور المحببة إليهم لإعادتهم إلى الطريق الصحيح، وهذا النوع من المعاملة هي المعاملة الصحيحة التي ينبغي أن تسير عليها الأسرة.

الوصايا الأساسية للتربية النفسية السليمة:

- تخصيص وقت كاف للجلوس مع الأبناء، وتبادل الأحاديث المتنوعة: الأخبار الاجتماعية والدراسية والثقافية.
- انشغال الأبوين المستمر وابتعادهما عن طفلهما يزرع في نفسه الالم ويعرضه للعقد والاضطرابات النفسية.
- التركيز على التربية الأخلاقية والمثل الطيبة، وأن يكون الوالدان قدوة حسنة لأبنائهما.
- احترام الأبناء عن طريق الاحترام المتبادل، وتنمية الوعي، والصراحة، والوضوح.
- الاكتشاف المبكر لأي خلل في سمع الطفل أو بصره يساعد في نجاح علاجه ويؤمن نموا نفسيا واجتماعيا له.
- قبول التنوع في اختيارات الأبناء الشخصية، كاختيار اللباس وبعض الهوايات وغيرها، طالما ليس فيها محاذير.
- الضرب والعقاب الجسدي لا يقوم سلوك الطفل بل يعلمه العدوانية وايذاء الاخرين عند الكبر.
- الجسم السليم مع عائلة مستقرة مع التربية والتعليم الصحيحين تؤمن بيئة النمو النفسي المناسب للطفل.
- التشجيع الدائم للأولاد والاستحسان والمدح؛ بل وتقديم الهدايا والمكافآت التشجيعية، كلما قدموا نجاحا في حياتهم.
- عدم السخرية والتهديد بالعقاب الدائم للأبناء، متى ما أخفقوا في دراستهم أو وقعوا في أخطاء من غير قصد منهم؛ بل يتم تلمس المشكلة بهدوء، ومحاولة التغلب على الخطأ بالحكمة، والترغيب والترهيب .
- ان تقويم السلوك المخطوء للطفل يعتمد على قدرة الأبوين والمعلمين/المدرسين في مد وتعزيز جسور الثقة المتبادلة.
- الابتعاد عن الخلافات العائلية والنزاعات أمام الأطفال يبعدهم عن العقد والاضطرابات النفسية.
- الأبوان والمعلمون/المدرسون هم القدوة والمثل الأعلى للأطفال، فهم يقلدونهم في حسناتهم وسيئاتهم والتصرف الصحيح أمام الطفل يعلمه الأخلاق الحميدة ويهذب شخصيته.
- ان الأسلوب الأمثل والأسهل لبناء الثقة المتبادلة بين المربي و الطفل هو ابداء الحب والاحترام الحقيقي للطفل والإصغاء له لفهم معاناته ومشاكله ومساعدته على حلها وإعطاؤه الثقة في نفسه.
- أن فترة تربية وتعليم الطفل في المدرسة هي فترة بالغة الأهمية فمن خلالها يمكن اكتشاف ومعالجة اي خطا في تنشئة الطفل وعلى نموه ونضجه النفسي واداءه في مجتمعه مستقبلا.

الفصل السابع: الحالات الخاصة :

الإعاقة البدنية (الجسدية): يعرف الفرد المصاب بالإعاقة الجسدية بأنه الفرد الذي يعاني من اضطراب بدني يعوق عملية تعليمه، أو نموه، أو توافقه، أسوة بأقرانه العاديين، هذه الاعاقات قد تؤدي إلى اضطرابات نفسية، مثل: (الاكتئاب، وضعف الثقة بالنفس). تصنف الإعاقة البدنية (الجسدية) إلى أربع أنواع رئيسية هي:

: الاضطرابات العصبية، مثل (الشلل الدماغي، وشلل الأطفال، والصرع،.... إلخ).

: الاضطرابات العظمية، مثل (الروماتيزم، والبتر،... إلخ.)

: المشكلات العضلية، مثل (الوهن العضلي).

: الأمراض المزمنة، مثل (السكري، والربو، الضغط،... إلخ).

كيفية تعامل المعلم/المدرس مع الطالب المعاق بدنيا:

- انتبه إلى استجابة الطالب النفسية.
- بذل الجهود لترسيخ استجابة إيجابية للتغلب على الصعوبات من قبل المعاق.
- يجب تنمية الاعتماد على النفس.
- التحدث مع الوالدين وإخبارهم أن الحماية الزائدة يمكن أن تؤدي إلى مشكلة نفسية، والذي قد يكون أشد خطورة من الحالة البدنية الأولية.
- التكيف مع المرض البدني المزمن، أو الإعاقة في مرحلة الطفولة أيسر منه في حياة البالغ.
- عدم النظر إلى الأشخاص المعاقين بدنيا بأنهم غير عاديين.

الاعتداءات الجنسية على الاطفال و اليافعين

- أصبح الاعتداء الجنسي على الاطفال واليافعين ظاهرة ذات أبعاد واسعة وخطيرة تهدد حياة الأطفال بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة.
- معظم هؤلاء الأطفال واليافعين يتعرضون للإعتداء الجنسي من قبل شخص يعرفونه ويثقون فيه سواء كان قريباً او صديقاً للعائلة او وصياً.
- كما يساهم الصمت فى استمرار الاعتداء الجنسي ويحمى المعتدين ويؤذي الاطفال خصوصا

مالمقصود بالأعتداء (العنف) الجنسي؟

الأعتداء الجنسي: هو كل فعل او قول او اشارة او همس له مدلول جنسي بدون موافقة او دراية الطرف الاخر .

أهم انواعه:

- ☒ الكلام البذيء والتحرش الجنسي.
- ☒ اللمسات والمداعبات الجنسية (المباشرة والغير مباشرة).
- ☒ مشاهدة الاطفال او اليافعين النشاطات الجنسية للكبار او الأفلام والصور الخليعة.
- ☒ جعل الاطفال او اليافعين يظهرون عراة فى الواقع أو بشكل جنسي فى الأفلام.
- ☒ عرض الاعضاء التناسلية على طفل او يافع بغية تأمين رضا جنسي ذاتي.

- ☒ تحريض الطفل او اليافع على لمس جسد المعتدي.
- ☒ تعريض الطفل او اليافع لمواد إباحية عبر الإنترنت .
- ☒ الاكراه الجنسي (الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب)

كيف يتم الأعتداء الجنسي للأطفال او اليافعين؟

من خلال:

- خداعهم
- او رشوتهم
- او تهديدهم
- او إجبارهم او الضغط عليهم
- يبدأ الاعتداء فى العادة تدريجيا

علامات الأعتداء الجنسي:

1. **التغيير السلوكي للطفل أواليافع:**
على الاهل والتربويين الانتباه للتغيرات السلوكية ومثال ذلك ملاحظة: الطفل او اليافع الذي يعانى من الاعراض السلوكية ليس مؤكد انه معتدى عليه جنسياً لانه قد يكون هناك اسباب اخرى لهذه الاعراض ولكن يجب وضع الاعتداء الجنسي على الطفل كأحد الاسباب المحتملة .

* اضطرابات سلوكية عدوانية
* تراجع مستوى الأداء الدراسي والاجتماعي
* اضطراب فى الاكل والنوم
* تقليد السلوك الجنسي للكبار
* قلة احترام وتقدير الذات
* إيذاء الذات
* تعاطى مخدرات او تدخين او سُكر
* اللعب الجنسي المستمر مع الاطفال ومع انفسهم
* ظهور معرفة جنسية من خلال السلوك واللغة تعتبر شاذة بالنسبة لأعمارهم
* التلميح او التعليق غير المباشر او العبارات العابرة عن الاعتداء
* خوف وكراهية لبعض الاشخاص او الاماكن
* اعراض القلق
* الكوابيس والرعب الليلي
* اعراض الاكتئاب
* النكوص لسلوك طفولى اقل من عمره مثل: مص الاصابع وسلس البول
* التأتأة في الكلام
* الانعزالية عن العائلة والاصدقاء والانشطة الاعتيادية
* الاستحمام الزائد او قلة النظافة

2. الأدلة البدنية:

ان الادلة البدنية للاعتداء الجنسي من النادر معرفتها,قد يتم ملاحظتها من قبل ألاهل, ويتم تشخيصها من قبل الطبيب .

دور المدرسة والهيئة التعليميّة في سبيل حماية الطلاب والقضاء على هذه الظاهرة، أوعلى الأقل التخفيف من وقوعها وذلك من خلال :

- يجب على الإدارة المدرسيّة تفعيل دور المراقبين في المدارس، والانتباه إلى الطالب خاصةً أوقات الاختلاط (الفسحة، الانصراف، أوقات النشاط الجماعي) ومتابعة دورات المياه والفصول في مثل هذه الأوقات .

-تشديد العقوبات من قِبَل إدارة المدرسة ضدَّ أي واقعة تحرُّش تقع في المدارس، سواء كانت من قِبَل طالب أو معلِّم أو موظَّف داخل المدرسة .

-تطوير ورفع مستويات العاملين في المؤسَّسات التعليميّة لتقديم التوجيه والإرشاد المناسب للطلّاب بشكلٍ عام .

-تقديم التوجيهات للطلَّاب بضرورة إخبار الأهل أو أيّ شخص بالغ من معلِّم أو مدير أو قريب في حال تعرُّضهم للتحرُّش الجنسي .

-يجب توعية أولياء الأمور من خلال عقد اجتماعات لهم وتقديم النصائح والإرشادات لهم في كيفيّة التعامُل مع أبنائهم في حال تعرُّضهم للتحرُّش الجنسي أو تعديهم على غيرهم. وتثقيفهم أيضاً بالأمور التي تدفع الأطفال للقيام بهذه التصرُّفات.

-يجب أن يكون هناك تعاون بين الإدارة المدرسيّة وأهل الطالب الضحيّة في كيفيّة تقديم المساعدة والدعم النفسي للطالب .

-يجب عقد جلسات إرشاديّة تُساعد الطالب المتحرَّش به على رفع ثقته بنفسه وتحسين التقدير الذاتي وتعليمه كيفيّة التعامُل مع مواقف مشابهة.

-تعليم الطفل أن يطلُب المساعدة من المعلِّم أو من أهله في حال تعرُّضه للمضايقة من أياً كان.

-مُتابعة مدى تحسُّن حالة الطالب ومستوى تحصيله العلمي .



الملاحق

الانشطة الترفيهية لتلبية احتياجات / اهتمامات الطلاب :

يمكن ان تلعب انشطة الترفيه او اللعب دورا هاما في تعزيز رفاه و مرونة الاطفال .فالمشاركة في الالعاب و الانشطة الترفيهية الاخرى توفر للاطفال الفرص لتنمية القدرات و الموارد التي يمكن ان تساعدهم على التعامل مع التحديات العاطفية و الاجتماعية و العملية التي قد يواجهونها في حياتهم و من انواع النشاط هذه :

- تستخدم **أنشطة الحرف** مجموعة متنوعة من المواد للطلاب لتشكيل الأعمال الفنية والتي يكن أن تشمل الفنون العصرية والرسم والتصوير .
- **الأعمال الدرامية** هي التي تمكن الطلاب من التعبير عن أنفسهم من خلال لعب الأدوار والتمثيل.
- تهدف **انشطة الالعاب** و الانشطة الرياضية إلى عرض تحدي معين أو تمرين على الطلاب ليقوموا بممارسته وتمارس هذه الانشطة في كثير من الاحيان في مجموعات أو فرق.
- **الأنشطة الموسيقية** هي الانشطة التي تنطوي على قيام الطلاب بممارسة الموسيقى.
- **انشطة الدمى** هي الأنشطة التي تنطوي على استخدام المعلم لدمية للمساعدة في تشجيع الطلاب على استكشاف أفكارهم ومشاعرهم.
- **أنشطة الاسترخاء** هي الأنشطة التي تهدف إلى تهدئة الطلاب وتشجيع توفير مساحة أمنة باستخدام التنفس وتمدد الجسم والتأمل الموجه.
- **أنشطة الفنون البصرية** هي الأنشطة التي تشمل الرسم والتصوير للتعبير عن الذات أو المجموعة.
- **أنشطة زراعية**

توفر هذه الأنشطة مساحة آمنة للطلاب من :

- الاستمتاع والنشاط .
- الهدوء والاسترخاء للتعبير عن مشاعرهم واستكشافها
- التعبير عما يدور في مخيلتهم.
- تعلم وتطبيق مهارات التركيز
- البدء في تأسيس اتصالات مع اقرانهم .

** نصيحة قبل تنفيذ النشاط : عليك مراعاة الطلاب الذين يعانون من اعاقات و قد لا يتمكنو من الحركة مثل غيرهم من الطلاب ، تأكد من اشراكهم بطريقة بناءة و تشاركية .

نشاط رقم 1 : تقليد الايقاع

- ✓ يشارك الطلاب في النشاط بتصفيق موسيقي قصير دون الحاجة إلى أي ادوات
- ✓ الاهداف : لتطوير مهارات التركيز والاستماع
- ✓ الخطوات:
  - اطلب من الطلاب الجلوس أو الوقوف في حلقة دائرية
  - التصفيق بإيقاع بسيط بحيث يسهل تكراره باستمرار
  - أخبر الطلاب بالمشاركة بنفس الإيقاع حتى يقوم الصف بأكمله بالتصفيق معا
  - عند تمكن جميع الطلاب من التصفيق معا يمكنك التوقف عن الإيقاع، والتصفيق على ايقاع مختلف
- ✓ دعنا نناقشا تقييم النشاط
  - ما الذي حدث خلال هذه اللعبة؟ كيف شعرت عندما كنا نصفق جميعاعلى نفس الإيقاع ؟
  - ما أهمية الاستماع إلى الآخرين لهذه اللعبة؟
  - كيف يمكننا تطبيق مهارات الاستماع هذه على اشياء أخرى نقوم بها معا ؟

نشاط رقم 2: شجرة في مهب الريح

يقوم الطلاب بالاسترخاء متضاهرين بانهم اشجار في مهب الريح في هذا النشاط القصير تحت اشراف المعلم.

-الاهداف :

- التعبير عما يدور في المخيلة
- الشعور بالهدوء
- تنمية الشعور بالوعي الذاتي

✓ الخطوات:

- اطلب من الطلاب الوقوف مع مد كلا الذراعين والمباعدة بين القدمين، وثني الركبتين قليلا
- اعط الإرشادات عندما أقول تهب الرياح- عليك التحرك بهدوء كما لو كانت الريح تهب عبر الأشجار والتلويح بذراعيك من جانب الى اخر وإلى الأمام وإلى الخلف مثل شجرة تهب عليها الريح
- اطلب من الطلاب إغلاق عيونهم وأخذ نفس عميق عدة مرات.
- بعد بضع دقائق اطلب منهم فتح أعينهم وتنزيل ايديهم .

✓ دعنا نناقش! تقييم النشاط:

- ما هو شعورك؟ هل هو مختلف عنما كان عليه عندما بدأنا النشاط؟
- هل تعتقد أن أنشطة الاسترخاء هذه مفيدة بالنسبة لك؟

نشاط رقم 3 : لمس الون الازرق

✓ يستخدم الطلاب مهارات التركيز للعثور على كائن مختلف بمجرد ان يطلب منهم المعلم او طالب ذلك على شكل لعبة ترافقه الموسيقى

✓ الأهداف:

- تنشيط وتحفيز الطلاب على المشاركة من خلال النشاط البدني
- تنمية وممارسة التركيز

✓ المواد: الموسيقى باستخدام آلة موسيقية مثل الطبل أو باستخدام هاتف ، كمبيوتر، قرص مضغوط .

✓ الخطوات:

- تقوم أنت أو أحد الطلاب بالعزف على آلة موسيقية أو ضبط تشغيل الموسيقي من جهاز.
- اخبر الجميع بأن عليهم التحرك في انحاء المكان أو الرقص السريع اثناء تشغيل الموسيقى .
- عندما تتوقف الموسيقى فان الشخص الذي يضبط الموسيقى ينادي (المس الون الازرق) او المس الأنف أو المس اي لون او كائن اخر في الغرفة ويجب ان يلمس الجميع هذا اللون او الكائن الموجود على شخص اخر وليس الموجود عليهم انفسهم .
- في كل مرة تبدا فيه الموسيقى يقوم المعلم بتغيير الامر .

✓ دعنا نناقش! تقييم النشاط :

- كيف تشعر الان؟
- هل تركز كثيرا على ايجاد ما أمرت بايجاده ؟
- كيف شعرت عندما كنت تبحث عن الامر وتمكنت من العثور عليه بسهولة؟
- وماذا عن المرات التي لم تتمكن فيها من العثور عليه ؟
- هل تعتقد أننا يمكن ان نركز على أمور أخرى بالمثابرة التي استخدمناها في هذه اللعبة؟

نشاط رقم 4 : خطى الجدة

- ✓ يستخدم الطالب مهارات التركيز لتجنب الامساك به من قبل الجدة في هذا النشاط القصير الممتع
- ✓ الأهداف:
  - تنشيط وتحفيز الطلاب على المشاركة من خلال النشاط البدني
  - تنمية وممارسة التركيز
- ✓ الخطوات: اختيار شخص يلعب دور «الجدة».
- ✓ شرح قواعد اللعبة:
- ✓ يقوم طالب بدور الجدة ويواجه الحائط في طرف الغرفة / المكان.
- ✓ يذهب بقية المجموعة إلى الطرف الآخر من المكان ويحاولوا التسلل بهدوء باتجاه الجدة.
- ✓ كلما استدارت الجدة ، على المجموعة أن تتوقف وتثبت تماما مكانها دون حراك - ويجب العودة إلى البداية إذا تحرك أي منهم.
- ✓ أول شخص يصل إلى الجدة ويلمسها برفق على الكتف يكون هو الفائز ويمكن أن ياخذ مكان الجدة .
- ✓ دعنا نناقش! تقييم النشاط:
  - من احب لعب دور الجدة ؟ ولماذا ؟
  - من الذي لم تمسكه الجدة مطلقا ؟ كيف كان شعورك بالنجاح في ذلك؟ باعتقادك ما سبب نجاحك ؟
  - هل تعتقد أننا يمكن أن نركز على أمور أخرى بالمثابرة التي استخدمناها في هذه اللعبة ؟

نشاط رقم 5 : قصص توضيحية

- ✓ تعبير الطلاب عن انفسهم من خلال رسم عناصر أو مشاهد من قصة مألوفة يعرفونها بالفعل
- ✓ الأهداف:
  - التعبير عن الخيال من خلال الإبداع.
  - زيادة الثقة بالنفس في التعبير باستخدام قصة مألوفة بهدف التوضيح .
- ✓ المواد:
  - قطعة كبيرة من الورق لكل طالب .
  - اقلام الشمع والباستيل الزيتي أو الطلاء .
- ✓ الخطوات
  - قم بقراءة أو سرد قصة يعرفها الطلاب .
  - بعد قراءة أو سرد القصة قم بتسليم الورق و الطباشير.
  - اطلب من الطلاب أن يتحدثوا عن الأجزاء التي اعجبتهم من القصة (فعلى سبيل المثال في قصة بياض الثلج يقول العديد من الطلاب التفاح، أو بياض الثلج أو الاقزام)
  - الحديث عما يمكن ان تبدو عليه هذه الأشياء والسماح للطلاب بالرسم كما يشاؤون وإذا لم يتمكن بعض الطلاب من الاختيار قم بمساعدتهم من خلال اقتراح شئ بسيط علي سبيل المثال :تفاحة جميلة كبيرة حمراء.
- ✓ دعنا نناقش! تقييم النشاط:
  - كيف كان شعورك وانت ترسم ما تتخيله عادة ؟
  - كيف تشعر حيال نفسك وانت تعرف انه يمكنك التعبير عن نفسك من خلال الفن؟

اهمية الصحة النفسية للمعلم / المدرس :

يعرف التدريس بأنه مهنة عالية الضغوطات، ومع ذلك هناك خطوات يمكن اتخاذها لإدارة مستويات الضغط والتوتر، وهذه مسألة هامة لإدارة الصف المدرسي.
يجب ان يكون المعلم هو نفسه متزنا خاليا من عوامل القلق و عدم الطمأنينة ، مؤمنا برسالته التربوية و فيما يلي بعض أفضل الممارسات لقضاء الوقت للرعاية الذاتية كمعلم (الرعاية الذاتية هي اي نشاط نقوم به عن قصد من اجل العناية بالصحة النفسية والعاطفية و الجسدية):

- يعمل الكثير من الناس حتى تنفذ طاقاتهم أو دون أن يأخذوا قسطاً من الراحة والنوم إلا بعد انتهاء العمل، لكن من المهم النظر إلى الراحة كأداة أساسية للإنتاجية، وقد تتخذ أشكالاً بسيطة كإطفاء الأنوار في الصف المدرسي لبضع دقائق بعد انتهاء الحصة.
- بالنسبة للعديد من الأشخاص تجدهم يتفحصون هواتفهم طوال اليوم ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني. إذا كان بإمكانك استبدال هذه الأوقات التي تقضيها على الهاتف بصمت وهدوء، فيمكن أن يحدث ذلك فرقاً في مستويات طاقتك وقدرتك على التركيز والانشاء.
- التفكير فيما يمكنك تركه والتخلي عنه لإيجاد مساحة للرعاية الذاتية، وهي الأوقات التي يصبح فيها الرفض أمراً حيوياً، وأحد أفضل الطرق للتحسن هو محاولة قول "لا" مرة واحدة فقط. إذا قلتها مرة واحدة فقط، فستجد أن الأشخاص سيتوقفون عن سؤالك عدة مرات لأنهم سيبدؤون باحترام حدودك ورغباتك.
- جعل الرعاية الذاتية جزءا من روتينك اليومي، على سبيل المثال، بمجرد مغادرة الطلاب المدرسة في نهاية الدوام ، خذ 60 ثانية للتنفس العميق لصفاء ذهنك وتنشيط أفكارك لتنفيذ بقية مهام اليوم. من الضروري أن تحدد أولوية لإنشاء عادة والالتزام بها .
- الاكل الجيد والحصول على قسط كاف من النوم و القيام بممارسة الرياضة البدنية كل يوم.
- القيام بممارسة نشاط تستمتع به او تجده مفيدا كل يوم و جعله روتينا في حياتك.
- تخصيص وقت من يومك للتحدث إلى صديق أو أحد أفراد الأسرة حول ما تشعر به.
- تجنب الإفراط في استخدام المواد التي تغير مزاجك أو مستوى طاقتك مؤقتاً (كالكافيين أو النيكوتين).
- كتابة قائمة بالأشياء الإيجابية التي حدثت في نهاية يومك و حاول ترك الأشياء الخارجة عن إرادتك وسيطرتك وعدم التفكير فيها.
- اخذ فترات راحة منتظمة طوال اليوم، ويمكنك خلال فترات الراحة هذه اتباع أساليب الاسترخاء المتوفرة ، علما أنه يمكنك أنت وطلابك استخدام هذه الأساليب.



تأملات

اختر الإجابة التي تعتقد أنها تصف العبارات التالية بدقة :

1. عندما أشعر أني لست بحال جيدة، فمن المرجح أن يقوم طلابي بما يلي :

أ.عدم الالتزام بقواعد الصف
ب.الشعور بالخوف وعدم الاستجابة.
ج. أداء أقل من المتوسط.
د. صعوبة في التركيز.
ه. جميع ما ذك

الاجابة (ه)

2. عندما أشعر أني بخير:

ا.اتحلى بمزيد من الصبر.
ب.اصبح افضل في ادارة الصف
ج.اصبح اكثر ابداعا
د. اصبح اكثر اهتماما باحتياجات طلابي
ه. جميع ما ذكر

الاجابة (ه)

اسماء المشاركون فى مراجعة الدليل :

	الاسم	مكان العمل
1-	د.منى عطا الله خليفة علي	مديرة قسم الوقاية و السيطرة على الامراض غير الانتقالية / دائرة الصحة العامة
2-	د.وسيم كيلان شاكر	مدير شعبة الصحة النفسية /وزارة الصحة
3-	د.نجوى عدنان عبد الجبار	شعبة الصحة النفسية /وزارة الصحة
4-	د.اسيل عبد الجبار	شعبة الصحة النفسية /وزارة الصحة
5-	سليم جياد كاظم	شعبة الصحة النفسية /وزارة الصحة
6-	نبأ محمد فخري	شعبة الصحة النفسية /وزارة الصحة
7-	رانية اسماعيل فاضل	شعبة الصحة النفسية /وزارة الصحة
8-	هند خليل محمد	شعبة الصحة النفسية /وزارة الصحة
9-	سعاد اللامي	منظمة اليونيسف/ قسم حماية الطفولة

المصادر

- اصدارات منظمة الصحة العالمية ومنها دليل رأب الفجوة الاصدار 2 /2016
- كتاب الصحة النفسية بيئة مدرسية داعمة للصحة النفسية الطلابية / حسام الدين طه عبد الحميد/2019
- استراتيجية الوقاية و السيطرة على الامراض غير الانتقالية للاعوام (2018 – 2024)
- وثيقة تعزيز الصحة في المدارس من البينات الى العمل
- مراحل النمو النفسي للطفل و متطلبات اهم المراحل العمرية / المقالات التربوية و الاسرية /2021
- اطروحات دكتوراه عن التنشئة الاجتماعية /2020
  https://www.psyco-dz.info/2017/12/pdf.html
- كتاب الصحة النفسية في الرعاية الصحية الاولية/اعداد د.اياد نوري فتاح/2013
- كتاب دليل الصحة النفسية المدرسية /لجنة الصحة النفسية المدرسية بوزارة التربية و التعليم /الرياض/2013
- الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية للاعوام (2018 – 2022)
- قانون مكتب الخدمات المدرسية النفسية و الاجتماعية من قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983الباب الثالث الوقاية /الفصل الاول الاكتشاف المبكر.
- خطة شعبة الصحة النفسية لعام 2022
- الانشطة الترفيهية للدعم النفسي و الاجتماعي – دليل مرجعي /2016
- حزمة اعداد المعلم / اليونيسف/2020